AMGEVITA (adalimumab) INSERTO PARA EL PROFESIONAL

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Adalimumab
Nombre Comercial: AMGEVITA®

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

AMGEVITA 20 mg solución inyectable en jeringa prellenada
Cada jeringa prellenada con una dosis única contiene 20 mg de adalimumab en 0,4 mL de solución (50 mg/mL).

AMGEVITA 40 mg solución inyectable en jeringa prellenada
Cada jeringa prellenada con una dosis única contiene 40 mg de adalimumab en 0,8 mL de solución (50 mg/mL).

AMGEVITA 40 mg solución inyectable en autoinyector prellenado
Cada autoinyector prellenado con una dosis única contiene 40 mg de adalimumab en 0,8 mL de solución (50 mg/mL).

Adalimumab es un anticuerpo monoclonal humano recombinante producido en células de Ovario de Hámster Chino.

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

3. FORMA FARMACÉUTICA

AMGEVITA 20 mg solución inyectable en jeringa prellenada
AMGEVITA 40 mg solución inyectable en jeringa prellenada
Solución inyectable (inyección).

AMGEVITA 40 mg solución inyectable en autoinyector prellenado (SureClick®)
Solución inyectable (inyección).

Solución transparente de incolora a ligeramente amarillenta.

4. DATOS CLÍNICOS

4.1 Indicaciones Terapéuticas

Adultos

Artritis reumatoide (AR): AMGEVITA está indicado para reducir los signos y síntomas e inhibir la progresión del daño estructural en pacientes adultos con artritis reumatoide moderada a severamente activa que no han respondido satisfactoriamente a uno o más agentes antirreumáticos modificadores de enfermedad (ARME). Puede emplearse solo o en combinación con metotrexato y otros agentes ARME.

Artritis psoriásica: AMGEVITA está indicado en la inhibición de la progresión del daño estructural y mejora en la función física en pacientes con artritis psoriásica.

Espondilitis anquilosante (EA):
Espondiloartritis axial no radiográfica (espondiloatritis axial sin evidencia radiográfica de EA): AMGEVITA está indicado para reducir los signos y síntomas en pacientes con espondiloartritis axial activa, no radiográfica, quienes tienen respuesta inadecuada, son intolerantes o tienen contraindicación para recibir AINES.

Psoriasis: AMGEVITA está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con psoriasis crónica en placa, de moderada a severa, que no han respondido a terapia sistémica o fototerapia.

Enfermedad de Crohn: AMGEVITA está indicado en pacientes con enfermedad de Crohn que no han respondido a la terapia convencional o han perdido respuesta o son intolerantes al infliximab. Adalimumab ha demostrado curación de la mucosa y cierre de la fístula en forma completa en pacientes con enfermedad de crohn moderada a severa ileocolónica. Adalimumab induce y mantiene la respuesta clínica a largo plazo y la remisión en pacientes con la enfermedad de Crohn moderada a severa, adalimumab reduce el riesgo de re-hospitalización y cirugía relacionada con la enfermedad de Crohn.

Colitis ulcerativa: AMGEVITA está indicado para el tratamiento de colitis ulcerativa activa, de moderada a severa, en pacientes adultos que han tenido una respuesta inadecuada a la terapia convencional, incluyendo corticosteroides y 6-mercaptopurina (*6-MP*) o azatioprina (*AZA*), o quienes son intolerantes a esas terapias o tienen contraindicaciones médicas para dichas terapias.

Hidradenitis supurativa (*HS*): AMGEVITA está indicado para el tratamiento de hidradenitis supurativa activa de moderada a severa (acné inverso) en pacientes adultos con respuesta inadecuada a la terapia sistémica convencional de la *HS*.

Uveitis: AMGEVITA está indicado para el tratamiento de uveítis no infecciosa intermedia, posterior y panuveitis en pacientes adultos que no han respondido previamente a la terapia con corticoides.

Pediatría

Artritis idiopática juvenil - Artritis idiopática juvenil poliarticular: AMGEVITA está indicado para reducir los signos y síntomas de la artritis idiopática juvenil poliarticular (*pJIA*, por sus siglas en inglés) activa, de moderada a severa, en pacientes de 2 años de edad y mayores. AMGEVITA puede usarse solo o en combinación con metotrexato.

Crohn pediátrico: AMGEVITA está indicado para reducir los signos y síntomas e inducir y mantener la remisión clínica en pacientes pediátricos, de 6 años de edad y mayores, con enfermedad de Crohn activa de moderada a severa que han tenido una respuesta inadecuada a la terapia convencional.

Psoriasis en placa en pediatría: Amgevita está indicado para el tratamiento de pacientes con psoriasis en placa crónica y severa, en niños y adolescentes a partir de los 4 años de edad, que han tenido una respuesta inadecuada o que son candidatos inapropiados para terapia tópica o fototerapia.

Artritis relacionada con entesitis: AMGEVITA está indicado para el tratamiento de artritis relacionada con entesitis, en pacientes de 6 años de edad y mayores, que han tenido una respuesta inadecuada, o que son intolerantes a la terapia convencional.

4.2 Posología y Forma de Administración

El tratamiento con AMGEVITA debe ser iniciado y supervisado por médicos especialistas con experiencia en el diagnóstico y el tratamiento de aquellas indicaciones autorizadas para AMGEVITA. Se aconseja a los oftalmólogos consultar con un especialista apropiado antes de iniciar el tratamiento con AMGEVITA (ver sección 4.4).

Tras un adecuado aprendizaje de la técnica de inyección, los pacientes pueden autoinyectarse AMGEVITA si el médico lo considera apropiado y les hace el seguimiento médico necesario.

Durante el tratamiento con AMGEVITA, se deben optimizar otros tratamientos concomitantes (p. ej., corticoesteroides y/o agentes inmunomoduladores).

Posología

Artritis reumatoide

La dosis recomendada de AMGEVITA para pacientes adultos con artritis reumatoide es 40 mg de adalimumab administrados en semanas alternas como dosis única en inyección por vía subcutánea. El metotrexato debe mantenerse durante el tratamiento con AMGEVITA.

Glucocorticoides, salicilatos, fármacos antiinflamatorios no esteroideos, o analgésicos pueden mantenerse durante el tratamiento con AMGEVITA. Para la combinación con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad distintos del metotrexato (ver secciones 4.4 y 5.1).

En monoterapia, los pacientes que experimenten una disminución en su respuesta con AMGEVITA 40 mg en semanas alternas pueden beneficiarse de un aumento de la dosis a 40 mg de adalimumab semanal u 80 mg cada dos semanas.

Los datos disponibles de adalimumab sugieren que la respuesta clínica normalmente se alcanza dentro de las 12 semanas de tratamiento. La continuación del tratamiento se debe reconsiderar en pacientes que no hayan respondido en este periodo de tiempo.

Interrupción del tratamiento

Puede ser necesario la interrupción del tratamiento, p. ej., antes de una cirugía o si se produce una infección grave.

Cuando se vuelve a iniciar el tratamiento con AMGEVITA tras una interrupción de 70 días de duración o superior, se debe obtener una respuesta clínica y un perfil de seguridad similar al observado antes de la interrupción del tratamiento.

Espondilitis anquilosante, espondiloartritis axial sin evidencia radiográfica de EA y artritis psoriásica

La dosis recomendada de AMGEVITA para pacientes con espondilitis anquilosante, espondiloartritis axial sin evidencia radiográfica de EA y para pacientes con artritis psoriásica es de 40 mg de adalimumab administrados en semanas alternas como dosis única en inyección por vía subcutánea.

Los datos disponibles sugieren que la respuesta clínica se consigue, por lo general, dentro de las primeras 12 semanas de tratamiento. La continuación con el tratamiento debe ser reconsiderada en los pacientes que no hayan respondido en este periodo de tiempo.

Psoriasis

La posología recomendada de AMGEVITA para pacientes adultos es de una dosis inicial de 80 mg por vía subcutánea, seguida de 40 mg administrados por vía subcutánea en semanas alternas comenzando una semana después de la dosis inicial.

La continuación del tratamiento tras 16 semanas debe reconsiderarse cuidadosamente en pacientes que no hayan respondido en este periodo de tiempo.

Tras 16 semanas, los pacientes con una respuesta inadecuada con AMGEVITA 40 mg en semanas alternas se pueden beneficiar de un incremento de la dosis a 40 mg semanales u 80 mg cada dos semanas. Los beneficios y riesgos de la continuación del tratamiento semanal con 40 mg u 80 mg cada dos semanas se deben reconsiderar cuidadosamente en pacientes con una respuesta inadecuada tras el incremento de la dosis (ver sección 5.1). Si se alcanza una respuesta adecuada con 40 mg semanales u 80 mg cada dos semanas, la dosis se puede reducir posteriormente a 40 mg en semanas alternas.

Hidradenitis supurativa

La posología recomendada de AMGEVITA para pacientes adultos con hidradenitis supurativa (*HS*) es de una dosis inicial de 160 mg en el día 1 (administrada como 4 inyecciones de 40 mg en un día o 2 inyecciones diarias de 40 mg en dos días consecutivos), seguida de 80 mg dos semanas después, en el día 15 (administrada como 2 inyecciones de 40 mg en un día). Dos semanas después (día 29) continuar con una dosis de 40 mg semanales u 80 mg cada dos semanas (administrada como dos inyecciones de 40 mg en un día). Si es necesario se puede continuar el tratamiento con antibióticos durante el tratamiento con AMGEVITA. Durante el tratamiento con AMGEVITA se recomienda que el paciente utilice a diario un líquido antiséptico tópico en las lesiones de *HS*.

La continuación del tratamiento tras 12 semanas debe reconsiderarse cuidadosamente en pacientes que no hayan presentado mejoría en este periodo de tiempo.

Si se necesita interrumpir el tratamiento, se puede reintroducir AMGEVITA 40 mg semanalmente u 80 mg cada dos semanas (ver sección 5.1).

Se debe evaluar periódicamente el balance beneficio/riesgo del tratamiento a largo plazo (ver sección 5.1).

Enfermedad de Crohn

El régimen de dosificación inicial recomendado de AMGEVITA para pacientes adultos con enfermedad de Crohn activa de moderada a grave es de 80 mg en la semana 0 seguido de 40 mg en la semana 2. En caso de que sea necesaria una respuesta más rápida al tratamiento, se puede cambiar la posología a 160 mg en la semana 0 (administrada mediante 4 inyecciones de 40 mg en un día o con 2 inyecciones de 40 mg por día durante dos días consecutivos), seguido de 80 mg en la semana 2 (administrada mediante dos inyecciones de 40 mg en un día), siendo consciente del mayor riesgo de reacciones adversas durante el inicio del tratamiento.

Después de iniciar el tratamiento, la dosis recomendada es de 40 mg administrados en semanas alternas vía inyección subcutánea. De forma alternativa, si un paciente interrumpe el tratamiento con AMGEVITA y los signos y síntomas de la enfermedad recurren, se puede readministrar AMGEVITA. Hay poca experiencia en la re-administración transcurridas más de 8 semanas desde la dosis previa.

Los corticosteroides se pueden reducir durante el tratamiento de mantenimiento, de acuerdo con las guías de práctica clínica.

Para algunos pacientes que han experimentado una disminución de su respuesta con AMGEVITA 40 mg en semanas alternas, puede ser beneficioso un aumento de la dosis de AMGEVITA 40 mg semanales u 80 mg cada dos semanas.

Para algunos pacientes que no han respondido al tratamiento en la semana 4, puede ser beneficioso continuar con un tratamiento de mantenimiento hasta la semana 12. El tratamiento continuado debe ser cuidadosamente reconsiderado en pacientes que no hayan respondido dentro de este periodo de tiempo.

Colitis ulcerativa

La dosis de inducción recomendada de AMGEVITA para pacientes adultos con colitis ulcerativa de moderada a grave es de 160 mg en la semana 0 (administrada mediante 4 inyecciones de 40 mg en un día o con 2 inyecciones de 40 mg por día durante dos días consecutivos) y 80 mg en la semana 2 (administrada mediante 2 inyecciones de 40 mg en un día). Después del tratamiento de inducción, la dosis recomendada es de 40 mg cada dos semanas mediante inyección subcutánea.

Los corticosteroides se pueden reducir durante el tratamiento de mantenimiento, de acuerdo con las guías de práctica clínica.

Para algunos pacientes que han experimentado una disminución de su respuesta con AMGEVITA 40 mg en semanas alternas puede ser beneficioso un aumento en la dosis a 40 mg semanales u 80 mg cada dos semanas.

La respuesta clínica se alcanza generalmente dentro de 2-8 semanas de tratamiento. El tratamiento con AMGEVITA no debería continuarse en pacientes que no respondan dentro de este período de tiempo.

Uveítis

La dosis recomendada de AMGEVITA para pacientes adultos con uveítis es de una dosis inicial de 80 mg, seguida de 40 mg administrado en semanas alternas comenzando una semana después de la dosis inicial. Hay experiencia limitada en el inicio del tratamiento con adalimumab en monoterapia. El tratamiento con AMGEVITA se puede iniciar en combinación con corticosteroides y/o con otro agente inmunomodulador no biológico. El tratamiento concomitante con corticosteroides puede ser ajustado de acuerdo con la práctica clínica comenzando dos semanas tras el inicio del tratamiento con AMGEVITA.

Se recomienda una evaluación anual del beneficio y riesgo del tratamiento continuado a largo plazo (ver sección 5.1).

Poblaciones especiales

Pacientes de edad avanzada

No se requiere ajuste de dosis.

Insuficiencia renal y/o hepática

Adalimumab no se ha estudiado en estas poblaciones de pacientes, por lo que no hay recomendaciones de dosis.

Población pediátrica

Artritis idiopática juvenil

Artritis idiopática juvenil poliarticular desde los 2 años de edad

La dosis recomendada de AMGEVITA para pacientes con artritis idiopática juvenil poliarticular, a partir de los 2 años de edad se basa en el peso corporal (tabla 1). AMGEVITA se administra en semanas alternas en inyección por vía subcutánea.

Tabla 1. Dosis de AMGEVITA para Pacientes con Artritis Idiopática Juvenil Poliarticular

Peso del Paciente	Pauta Posológica
10 kg hasta < 30 kg	20 mg en semanas alternas
≥ 30 kg	40 mg en semanas alternas

La respuesta clínica se consigue, por lo general, dentro de las primeras 12 semanas de tratamiento. La continuación con el tratamiento debe ser reconsiderada cuidadosamente en los pacientes que no hayan respondido en este periodo de tiempo.

No hay un uso relevante de adalimumab en pacientes menores de 2 años para esta indicación.

Artritis asociada a entesitis

La dosis recomendada de AMGEVITA para pacientes con artritis asociada a entesitis en pacientes a partir de 6 años se basa en el peso corporal (tabla 2). AMGEVITA se administra en semanas alternas en inyección por vía subcutánea.

Tabla 2. Dosis de AMGEVITA para Pacientes con Artritis Asociada a Entesitis

Peso del Paciente	Pauta Posológica
15 kg hasta < 30 kg	20 mg en semanas alternas
≥ 30 kg	40 mg en semanas alternas

No se ha estudiado el uso de adalimumab en pacientes con artritis asociada a entesitis menores de 6 años.

Psoriasis pediátrica en placa

La dosis recomendada de AMGEVITA para pacientes con psoriasis pediátrica en placas desde los 4 años de edad se basa en el peso corporal (tabla 3). AMGEVITA se administra en inyección por vía subcutánea.

Tabla 3. Dosis de AMGEVITA para Pacientes Pediátricos con Psoriasis en Placa

Peso del Paciente	Pauta Posológica
15 kg hasta < 30 kg	Dosis inicial de 20 mg, seguida de 20 mg administrados en semanas alternas empezando una semana después de la dosis inicial
≥ 30 kg	Dosis inicial de 40 mg, seguida de 40 mg administrados en semanas alternas empezando una semana después de la dosis inicial

La continuación del tratamiento más allá de 16 semanas se debe reconsiderar de forma cuidadosa en pacientes que no hayan respondido en este periodo de tiempo.

En el caso de que esté indicado el retratamiento con AMGEVITA, se deben seguir las indicaciones anteriores en cuanto a la dosis y la duración del tratamiento.

La seguridad de adalimumab en pacientes pediátricos con psoriasis en placas ha sido evaluada durante una media de 13 meses.

No existe una recomendación de uso específica para adalimumab en niños menores de 4 años para esta indicación.

Enfermedad de Crohn pediátrica

La dosis recomendada de AMGEVITA para pacientes con enfermedad de Crohn desde los 6 años de edad se basa en se basa en el peso corporal (tabla 4). AMGEVITA se administra en inyección por vía subcutánea.

Tabla 4. Dosis de AMGEVITA para Pacientes Pediátricos con enfermedad de Crohn

Peso del Paciente	Dosis de Inducción	Dosis de Mantenimiento empezando en la Semana 4
< 40 kg	• 40 mg en la semana 0 y 20 mg en la semana 2 En caso de que sea necesario una respuesta más rápida al tratamiento siendo conscientes de que el riesgo de los efectos adversos podría aumentar con el uso de una dosis de inducción mayor, se puede usar la siguiente dosis: • 80 mg en la semana 0 y 40 mg en la semana 2	20 mg cada dos semanas
≥ 40 kg	• 80 mg en la semana 0 y 40 mg en la semana 2 En caso de que sea necesario una respuesta más rápida al tratamiento siendo conscientes de que el riesgo de los efectos adversos podría aumentar con el uso de una dosis de inducción mayor, se puede usar la siguiente dosis: • 160 mg en la semana 0 y 80 mg en la semana 2	40 mg cada dos semanas

Pacientes que tengan una respuesta insuficiente pueden beneficiarse de un aumento de la dosis:
- < 40 kg: 20 mg cada semana
- ≥ 40 kg: 40 mg cada semana u 80 mg cada dos semanas

El tratamiento continuado debe ser cuidadosamente reconsiderado en pacientes que no hayan respondido en la semana 12.

No existe un uso relevante de adalimumab en niños menores de 6 años para esta indicación.

Forma de administración

AMGEVITA se administra mediante inyección subcutánea. Las instrucciones completas para su uso se describen en el inserto.

4.3 Contraindicaciones

No se debe administrar AMGEVITA a pacientes con hipersensibilidad conocida a adalimumab o a cualquiera de los excipientes.
Tuberculosis activa u otras infecciones graves tales como sepsis, e infecciones oportunistas. Insuficiencia cardiaca moderada a grave (*NYHA* clases III/IV).

4.4 Advertencias y Precauciones Especiales de Uso

Con el fin de mejorar la trazabilidad de los productos medicinales biológicos, la marca comercial y el número de lote del producto administrado deben ser registrados claramente.

4.4.1 Infecciones

Infecciones serias debidas a infecciones bacterianas, micobacterianas, micóticas invasivas (histoplasmosis diseminada o extrapulmonar, aspergilosis, coccidioidomicosis), virales, por parásitos u otras infecciones oportunistas, han sido reportadas en pacientes que reciben agentes bloqueadores del *TNF*. También se ha reportado sepsis, casos raros de tuberculosis, candidiasis, listeirosis, legionelosis y neumocistis con el uso de los antagonistas del *TNF*, incluyendo adalimumab. Otras infecciones serias observadas en ensayos clínicos incluyen neumonía, pielonefritis, artritis séptica y

septicemia. Se han reportado hospitalizaciones o resultados fatales asociados con infecciones. Muchas de las infecciones serias han ocurrido en pacientes bajo tratamiento concomitante con agentes inmunosupresores que, junto con su enfermedad subyacente, pudieron haberlos predispuesto a las infecciones.

El tratamiento con AMGEVITA no debe iniciarse en pacientes con infecciones activas, incluyendo infecciones crónicas o localizadas, hasta que las infecciones estén controladas. Los pacientes que hayan estado expuestos a tuberculosis y en pacientes que hayan viajado a áreas de alto riesgo de tuberculosis o endémicas para enfermedades micóticas, tales como histoplasmosis, coccidioidomicosis o blastomicosis, se debe considerar el riesgo y los beneficios del tratamiento con AMGEVITA antes de comenzar la terapia (ver Advertencias y Precauciones Especiales de Uso – Otras Infecciones Oportunistas).

Como ocurre con otros antagonistas del *TNF*, los pacientes deberán ser estrechamente controlados por infecciones, incluyendo la tuberculosis, antes, durante y después del tratamiento con AMGEVITA.

Los pacientes que desarrollen una infección nueva mientras reciben tratamiento con AMGEVITA deben ser vigilados estrechamente y recibir una evaluación diagnóstica completa. La administración de AMGEVITA debe suspenderse si un paciente presenta una nueva infección seria o sepsis y se debe iniciar la terapia antimicrobiana o antimicótica apropiada, hasta que las infecciones estén controladas.

Los médicos deben tener precaución al considerar el uso de AMGEVITA en pacientes con antecedentes de infecciones recurrentes o con condiciones subyacentes que puedan predisponer a los pacientes a infecciones.

4.4.2 Tuberculosis

Se ha reportado tuberculosis, incluyendo reactivación y nuevos casos de tuberculosis, en pacientes bajo tratamiento con adalimumab. Los reportes incluyen casos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar (es decir, diseminada).

Antes de iniciar la terapia con AMGEVITA, todos los pacientes deben ser evaluados por infección de tuberculosis tanto activa e inactiva (“latente”). Esta evaluación debe incluir una evaluación médica detallada de la historia del paciente en lo que respecta a tuberculosis o cualquier posible exposición previa a personas con tuberculosis activa y una terapia inmunosupresora previa y/o actual. Se deben realizar pruebas de tamizaje apropiadas de acuerdo con las recomendaciones locales (p. ej., radiografía de tórax y prueba cutánea de tuberculina). Debe iniciarse el tratamiento de las infecciones latentes por tuberculosis antes de la terapia con AMGEVITA. Cuando se realiza la prueba cutánea de tuberculina para detección de la infección de tuberculosis latente se debe considerar positivo un tamaño de induración de 5 mm o mayor, aún si el paciente se ha vacunado previamente con el Bacilo de Calmette-Guerin (*BCG*) +.

La posibilidad de tuberculosis latente no detectada se debe considerar especialmente en pacientes que han inmigrado o viajado a países con alta prevalencia de tuberculosis o quienes hayan tenido contacto cercano con una persona con tuberculosis activa.

Si se diagnostica tuberculosis activa no se debe iniciar la terapia con AMGEVITA.

Si se diagnostica tuberculosis latente se debe iniciar el tratamiento adecuado con tratamiento profiláctico antituberculoso antes de iniciar el tratamiento con AMGEVITA, de acuerdo con las recomendaciones locales. El uso del tratamienro profiláctico antituberculoso también debe considerarse antes de iniciar el tratamiento con AMGEVITA en los pacientes con varios o significativos factores de riesgo de tuberculosis, a pesar de que presenten una prueba negativa para tuberculosis, y en pacientes con historia de tuberculosis latente o activa en los cuales no se puede confirmar que haya un curso adecuado del tratamiento. La decisión de iniciar una terapia antituberculosa en estos pacientes sólo se debe tomar luego de evaluar el riesgo de infección por

tuberculosis latente y los riesgos de la terapia antituberculosa. Si es necesario, se debe consultar con un médico con experiencia en el tratamiento de la tuberculosis.

El tratamiento antituberculoso de pacientes con infección de tuberculosis latente reduce el riesgo de reactivación en pacientes que reciben tratamiento con AMGEVITA. A pesar del tratamiento profiláctico para tuberculosis, han ocurrido casos de reactivación de tuberculosis en pacientes bajo tratamiento con adalimumab. Asimismo, se ha desarrollado tuberculosis activa en pacientes que reciben adalimumab cuya prueba de tamizaje para la infección por tuberculosis latente fue negativa y algunos pacientes que han sido tratados exitosamente contra tuberculosis activa han vuelto a desarrollar tuberculosis al ser tratados con agentes bloqueadores del *TNF*.

Los pacientes que reciben AMGEVITA deben ser vigilados por signos y síntomas de tuberculosis activa, particularmente porque las pruebas para infección por tuberculosis latente pueden ser falsos negativos. El riesgo de resultados falsos negativos en una prueba cutánea de tuberculina se debe considerar especialmente en pacientes severamente enfermos o inmunocomprometidos.

Se debe instruir a los pacientes que deben buscar la asesoría médica si se presentan signos/síntomas que sugieran una infección de tuberculosis (p. ej., tos persistente, pérdida de peso, febrícula, languidez) durante o después de la terapia con AMGEVITA. Según sea permitido por las regulaciones locales.

4.4.3 Otras Infecciones Oportunistas

Se han observado infecciones oportunistas, incluyendo infecciones micóticas invasivas en pacientes que reciben adalimumab. Estas infecciones no se reconocen de manera consistente en los pacientes que reciben bloqueadores del *TNF*, lo cual ha resultado en retrasos del tratamiento apropiado, resultando algunas veces en desenlaces fatales.

Los pacientes que toman bloqueadores del *TNF* son más susceptibles a infecciones micóticas serias, como histoplasmosis, coccidioisimicosis, blastomicosis, aspergilosis, candidiasis y otras infecciones oportunistas. Aquellos pacientes que desarrollen fiebre, malestar, pérdida de peso, sudoración, tos, disnea y/o infiltrados pulmonares u otras enfermedades sistémicas serias, con o sin shock concomitante, deben buscar de inmediato atención médica para una evaluación diagnóstica.

Para los pacientes que residen o que viajan a regiones donde las micosis son endémicas, se debe sospechar de infecciones micóticas invasivas si ellos desarrollan los signos y síntomas de posible infección micótica sistémica. Los pacientes están en riesgo de histoplasmosis y de otras infecciones micóticas invasivas y por lo tanto los médicos deben considerar un tratamiento antimicótico empírico hasta que el o los patógenos sean identificados. La prueba de antígeno y anticuerpo para histoplasmosis puede ser negativa en algunos pacientes con infección activa. Cuando sea factible, la decisión de administrar una terapia empírica antimicótica en estos pacientes, debe hacerse consultando un médico con experiencia en el diagnóstico y tratamiento de infecciones micóticas invasivas y debe tomarse en cuenta el riesgo de infección micótica severa y los riesgos de la terapia antimicótica. Se recomienda detener el uso de los bloqueadores del *TNF* en los pacientes que desarrollan una infección micótica severa hasta que la infección sea controlada.

4.4.4 Reactivación de la Hepatitis B

El uso de agentes bloqueadores de *TNF* se ha asociado con reactivación del virus de la hepatitis B (VHB) en pacientes que son portadores crónicos de este virus. En algunos casos, la reactivación del VHB que ocurre junto con la terapia bloqueadora del *TNF* ha sido fatal. La mayoría de estos reportes han ocurrido en pacientes que reciben concomitantemente otras medicaciones supresoras del sistema inmune, lo cual también puede contribuir a la reactivación del VHB. Los pacientes en riesgo de infección por VHB deben evaluarse para establecer una evidencia previa de infección por VHB, antes de iniciar la terapia bloqueadora del *TNF*. Los médicos deben tener precaución al prescribir bloqueadores del *TNF* en pacientes identificados como portadores del VHB. Los pacientes que son portadores del VHB y que requieren tratamiento con bloqueadores del *TNF* deben ser vigilados estrechamente por signos y síntomas de infección activa para VHB durante la terapia y por varios

meses posteriores a su finalización. No hay información disponible sobre la seguridad o eficacia de los pacientes tratados que son portadores del VHB, con terapia antiviral en conjunto con terapia bloqueadora del *TNF* para prevenir la reactivación del VHB. En pacientes que desarrollan reactivación del VHB, debe suspenderse la administración de AMGEVITA y se debe iniciar una terapia antiviral efectiva con tratamiento de soporte apropiado.

4.4.5 Episodios Neurológicos

Los antagonistas del *TNF*, incluyendo adalimumab, se han asociado con casos de reciente aparición o exacerbación de síntomas clínicos y/o evidencia radiográfica de enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, incluyendo esclerosis múltiple, neuritis óptica y enfermedad desmielinizante periférica, incluyendo el síndrome de Guillain-Barré. Los médicos deben tener precaución en considerar el uso de AMGEVITA en pacientes con trastornos desmielinizantes del sistema nervioso central o periférico, preexistentes o de reciente aparición; la descontinuación de AMGEVITA debe ser considerada si alguno de estos trastornos se desarrolla. Hay una asociación conocida entre uveítis intermedia y trastornos centrales desmielinizantes. Una evaluación neurológica deber ser llevada a cabo en pacientes con uveítis intermedia no infecciosa antes de la iniciación de la terapia con AMGEVITA para evaluar trastornos centrales desmielinizantes preexistentes.

4.4.6 Neoplasias

En las fases controladas de los ensayos clínicos de los antagonistas del *TNF*, se han observado entre los pacientes que reciben un antagonista del *TNF*, comparados con los pacientes control, más casos de neoplasias incluyendo linfomas.

El tamaño del grupo control y la duración limitada de las secciones controladas de los estudios no permite llegar a conclusiones firmes. Además, existe un antecedente incrementado de riesgo de linfoma en los pacientes con artritis reumatoide con enfermedad inflamatoria prolongada y altamente activa, lo que complica la evaluación del riesgo.

Durante los ensayos de etiqueta abierta a largo plazo con adalimumab, la tasa general de neoplasias fue similar a la esperada para una población general comparada por edad, género y etnia. Con el conocimiento actual, no puede excluirse un posible riesgo de desarrollo de linfomas u otras neoplasias en pacientes tratados con un antagonista del *TNF*.

Se han reportado neoplasias, algunas fatales, entre niños y adolescentes quienes han recibido tratamiento con agentes bloqueadores del *TNF*. Aproximadamente la mitad de los casos fueron linfomas, incluyendo linfoma de Hodgkin y no-Hodgkin. Los otros casos representan una variedad de diferentes neoplasias e incluían neoplasias raras usualmente asociadas con inmunosupresión. Las neoplasias ocurrieron luego de una media de 30 meses de terapia. La mayoría de los pacientes estaban recibiendo inmunosupresores concomitantemente. Estos casos fueron reportados postcomercialización y son derivados de una variedad de fuentes incluyendo registros y reportes espontáneos postcomercialización.

Después de la comercialización se han identificado reportes muy raros de linfomas de células T hepatoesplénicas (*HSTCL*, por sus siglas en inglés), un linfoma raro y agresivo que a menudo es fatal, en pacientes tratados con adalimumab. La mayoría de estos pacientes recibieron terapias previas con infliximab al igual que el uso concomitante de azatioprina o 6-mercaptopurina, para la enfermedad inflamatoria intestinal. Se debería considerar el riesgo potencial con la combinación de azatioprina o 6-mercaptopurina y adalimumab. No es clara la asociación causal del *HSTCL* con adalimumab.

No se han realizado estudios que incluyan pacientes con una historia de neoplasia ni sobre el tratamiento continuo en pacientes que desarrollan neoplasia mientras reciben adalimumab. Por consiguiente, debe ejercerse precaución adicional al considerar el tratamiento de estos pacientes con AMGEVITA.

Todos los pacientes y en particular aquellos con una historia médica de terapia inmunosupresora extensa, o pacientes con psoriasis con una historia de tratamiento con Psoralen y rayos *UVA* (*PUVA*), deben ser examinados para descartar la presencia de cáncer de piel de tipo no melanoma antes y durante el tratamiento con AMGEVITA.

Se han reportado casos de leucemia aguda y crónica asociados con el uso postcomercialización de un bloqueador del *TNF* en artritis reumatoide y otras indicaciones. Los pacientes con artritis reumatoide pueden presentar un riesgo mayor (hasta del doble) que la población general para el desarrollo de leucemia, incluso en ausencia de terapia con bloqueador de *TNF*.

Con los datos disponibles actualmente, se desconoce si el tratamiento con adalimumab influye en el riesgo de desarrollo de displasia o cáncer de colon. Todos los pacientes con colitis ulcerativa que están en riesgo de displasia o carcinoma de colon (p. ej., pacientes que han padecido colitis ulcerativa desde hace mucho tiempo o colangitis esclerosante primaria) o que tenían una historia previa de displasia o carcinoma de colon, deben ser evaluados para displasia a intervalos regulares antes de la terapia y a lo largo del curso de la enfermedad. Esta evaluación debe incluir colonoscopía y biopsias, según recomendaciones locales.

4.4.7 Alergias

Las reacciones alérgicas serias asociadas con adalimumab en los estudios clínicos fueron raras. Se han recibido reportes de reacciones alérgicas serias incluyendo reacciones anafilácticas después de la administración de adalimumab.

Si se presentara una reacción anafiláctica u otra reacción alérgica seria, deberá suspenderse inmediatamente la administración de AMGEVITA e iniciarse la terapia apropiada.

El capuchón de la aguja del autoinyector prellenado está fabricado con caucho natural (un derivado del látex), que puede causar reacciones alérgicas.

4.4.8 Reacciones Hematológicas

Se han hecho reportes aislados de pancitopenia incluyendo la anemia aplásica con los agentes bloqueadores del *TNF*. Eventos adversos del sistema hematológico, incluyendo citopenia médicamente significativa (p. ej., trombocitopenia, leucopenia) se han reportado con adalimumab. No es clara la relación causal de estos reportes con el uso de adalimumab. A todos los pacientes se les debe aconsejar solicitar atención médica inmediata si desarrollan signos o síntomas sugerentes de discrasias sanguíneas (p. ej., fiebre persistente, hematoma, hemorragias, palidez) mientras reciben AMGEVITA. Se debe considerar la descontinuación de la terapia con AMGEVITA en pacientes con anormalidades hematológicas significativas confirmadas.

4.4.9 Administración Concomitante de FARMEs Biológicos o Antagonistas del *TNF*

Durante estudios clínicos se observaron infecciones serias debidas al uso concomitante de anakinra, otros antagonistas del *TNF* y etanercept, con ningún beneficio clínico adicional comparado con etanercept solo. Debido a la naturaleza de los eventos adversos observados con la terapia que combina etanercept y anakinra, pueden resultar toxicidades similares de la combinación de anakinra con otros antagonistas del *TNF*. Por lo tanto, la combinación de adalimumab y anakinra no es recomendada.

La administración concomitante de adalimumab con otros FARMEs biológicos (p. ej., anakinra y abatacept) u otros antagonistas del *TNF* no es recomendada, debido al posible aumento en el riesgo de infecciones y otras interacciones farmacológicas potenciales.

4.4.10 Inmunosupresión

En un estudio que incorporó 64 pacientes con AR tratados con adalimumab, no hubo evidencia de depresión de la hipersensibilidad retardada, disminución de los niveles de inmunoglobulina, ni cambio

los recuentos de células B y T efectoras ni en las células asesinas naturales (*NK*, por sus siglas en inglés), monocitos/macrófagos ni neutrófilos.

4.4.11 Vacunas

En un estudio aleatorio, doble ciego, controlado con placebo realizado a 226 pacientes adultos con artritis reumatoide con adalimumab, se evaluaron las respuestas del anticuerpo a la administración concomitante de las vacunas del neumococo y de la influenza. Se lograron niveles de anticuerpos protectores a los antígenos del neumococo en 86% de los pacientes tratados en el grupo adalimumab en comparación con 82% en el grupo de placebo. Un total de 37% de los pacientes tratados con adalimumab y 40% de los tratados con placebo logró un incremento de al menos dos veces en al menos tres de cinco antígenos del neumococo. En el mismo estudio, 98% de los pacientes tratados con adalimumab y 95% de los tratados con placebo lograron niveles protectores de anticuerpos a los antígenos de la influenza. Un total de 52% de los pacientes tratados con adalimumab y 63% de los tratados con placebos logró al menos un incremento de cuatro veces en al menos dos de tres de los antígenos de la influenza.

Se ha recomendado que los pacientes pediátricos, si es posible, actualicen todas las inmunizaciones según las directrices actuales de inmunización, antes de comenzar la terapia con AMGEVITA.

Los pacientes que se tratan con AMGEVITA pueden recibir simultáneamente vacunas exceptuando las vacunas vivas. No hay datos disponibles sobre la transmisión secundaria de infección por vacunas vivas en pacientes tratados con adalimumab.

No se recomienda la administración de vacunas vivas a infantes que estuvieron expuestos a adalimumab en el útero, por 5 meses después de la última inyección de adalimumab administrada a la madre durante el embarazo.

4.4.12 Insuficiencia Cardiaca Congestiva

Adalimumab no ha sido estudiado formalmente en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva (ICC), sin embargo, se ha reportado en estudios clínicos con otros antagonistas del *TNF* una tasa más alta de eventos adversos relacionados con la ICC, incluyendo empeoramiento de la ICC y nueva aparición de ICC. Se han reportado también casos de empeoramiento de la ICC en pacientes que reciben adalimumab. AMGEVITA debe utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia cardiaca leve (*NYHA* clases I/II). AMGEVITA está contraindicado en insuficiencia cardiaca moderada o grave. El tratamiento con AMGEVITA debe interrumpirse en pacientes que desarrollen insuficiencia cardiaca congestiva nueva o presenten un empeoramiento de los síntomas.

4.4.13 Procesos Autoinmunes

El tratamiento con AMGEVITA puede resultar en la formación de anticuerpos autoinmunes.

Se desconoce el impacto del tratamiento con adalimumab a largo plazo en el desarrollo de enfermedades autoinmunes.

Si un paciente desarrolla síntomas sugerentes de un síndrome similar al lupus después del tratamiento con AMGEVITA, la terapia debe descontinuarse (ver Reacciones Adversas – Autoanticuerpos).

4.4.14 Uso Geriátrico

La frecuencia de infección grave entre los individuos mayores de 65 años de edad tratados con adalimumab fue más alta que para los individuos menores de 65 años de edad. Del número total de individuos en los estudios clínicos con adalimumab, el 9,4% era de 65 años o mayores, mientras que aproximadamente el 2,0% era de 75 años y mayores. Debido a que existe una incidencia más alta de infecciones en la población de personas de edad avanzada en general, debe tenerse precaución al tratar a estas personas.

4.4.15 Embarazo y Lactancia

Embarazo

Se realizó un estudio de desarrollo de toxicidad perinatal embrio-fetal en monos *cynomolgus* a dosis hasta de 100 mg/kg (373 veces el área bajo la curva (ABC) humano) cuando se administraron 40 mg por vía subcutánea (SC), el cual no evidenció daño fetal asociado con adalimumab.

En un estudio prospectivo de registro de exposición durante el embarazo, 257 mujeres con AR (artritis reumatoidea) o *CD* (por sus siglas en inglés, enfermedad de Crohn), fueron tratadas con adalimumab al menos durante el primer trimestre y 120 mujeres con AR (artritis reumatoidea) o *CD* (enfermedad de Crohn) no tratadas con adalimumab fueron enroladas.

No se presentaron diferencias significativas en las tasas generales del criterio de valoración primario del estudio o defectos de nacimiento mayores (Odds Radio ajustado 0,84%, intervalo de confianza (*CI*) 0,34; 2,05) así como para los criterios de valoración secundarios del estudio los cuales incluyeron defectos de nacimiento menores, aborto espontáneo, parto prematuro, bajo peso al nacer e infecciones serias u oportunistas.

No se reportaron mortinatalidad o neoplasias. Este estudio no puede descartar de manera confiable si existe una asociación entre adalimumab y los defectos congénitos mayores debido a las limitaciones metodológicas del registro, incluido el tamaño pequeño de la muestra, la naturaleza voluntaria del estudio y el diseño no aleatorizado. Adicionalmente, la información de vigilancia post mercadeo no establece la presencia de riesgos asociados al medicamento.

Adalimumab puede cruzar la placenta hacia el suero de los infantes nacidos de mujeres bajo tratamiento con adalimumab durante el embarazo. Por consiguiente, estos infantes pueden tener mayor riesgo de infecciones.

No se recomienda la administración de vacunas vivas a infantes que estuvieron expuestos a adalimumab en el útero, por 5 meses después de la última inyección de adalimumab administrada a la madre durante el embarazo.

Trabajo de parto y parto

No se conocen los efectos de adalimumab en el trabajo de parto o parto.

Madres en periodo de lactancia

Información limitada incluida en literatura publicada, indica que adalimumab es excretado en la leche materna a muy bajas concentraciones, con presencia de adalimumab en leche humana a concentraciones de 0,1% a 1% del nivel de suero materno.

Dada la proteólisis intestinal a la que se someten y la baja biodisponibilidad de las inmunoglobulinas G ingeridas por vía oral, efectos sistémicos del adalimumab sobre un infante en lactancia materna son improbables.

Los beneficios de la lactancia materna para el desarrollo y la salud deberían ser considerados junto con la necesidad clínica de adalimumab de la madre, así como cualquier potencial efecto adverso sobre el lactante, de adalimumab o desde las condiciones subyacentes de la madre.

4.5 Interacciones con Otros Medicamentos y Otras Formas de Interacción

Adalimumab ha sido estudiado en pacientes con artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil poliarticular y artritis psoriásica tratados con adalimumab tanto en monoterapia como con metotrexato de forma concomitante. Cuando se administró adalimumab junto con metotrexato, la formación de anticuerpos fue inferior en comparación con el uso como monoterapia. La administración de

adalimumab sin metotrexato resultó en un incremento de la formación de anticuerpos, del aclaramiento y redujo la eficacia de adalimumab (ver sección 5.1).

La administración conjunta de adalimumab y anakinra no está recomendada (ver sección 4.4 “Administración Concomitante de FARMEs Biológicos o Antagonistas del *TNF*”).

La administración conjunta de adalimumab y abatacept no está recomendada (ver sección 4.4 “Administración Concomitante de FARMEs Biológicos o Antagonistas del *TNF*”).

4.6 Efectos Sobre la Capacidad de Conducir y Utilizar Máquinas

La influencia de AMGEVITA sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña. Se pueden producir vértigos y alteraciones de la visión tras la administración de AMGEVITA (ver sección 4.7).

4.7 Reacciones Adversas

Resumen del perfil de seguridad

Adalimumab se ha estudiado en 9.506 pacientes en ensayos pivotales controlados y abiertos durante un máximo de 60 meses o más. Estos ensayos clínicos incluyeron pacientes con artritis reumatoide reciente o de larga duración, artritis idiopática juvenil (artritis idiopática juvenil poliarticular y artritis asociada a entesitis) así como con espondiloartritis axial (espondilitis anquilosante, y espondiloartritis axial sin evidencia radiográfica de EA), artritis psoriásica, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, psoriasis, hidradenitis supurativa y uveítis. Los datos están basados en ensayos pivotales controlados que abarcaron 6.089 pacientes tratados con adalimumab y 3.801 pacientes con placebo o comparador activo durante el periodo controlado.

La proporción de pacientes que interrumpió el tratamiento debido a reacciones adversas durante la fase doble ciego y controlada de los ensayos pivotales fue 5,9% para los pacientes tratados con adalimumab y 5,4% para el grupo control.

Las reacciones adversas notificadas más frecuentemente fueron infecciones (como nasofaringitis, infección del tracto respiratorio superior y sinusitis), reacciones en el lugar de inyección (eritema, picores, hemorragia, dolor o hinchazón), cefalea y dolor músculo esquelético.

Se han notificado reacciones adversas graves con adalimumab. Los antagonistas del *TNF*, como AMGEVITA, afectan al sistema inmune, y su uso puede afectar a la defensa del cuerpo contra infecciones y cáncer.

Se han notificado también en asociación con el uso de adalimumab infecciones mortales o que amenazan la vida del paciente (incluyendo sepsis, infecciones oportunistas y tuberculosis), reactivación del VHB y varios tipos de tumores (incluyendo leucemia, linfoma y linfoma hepatoesplénico de células T).

También se han notificado reacciones hematológicas, neurológicas y autoinmunes graves. Estas incluyen notificaciones raras de pancitopenia, anemia aplásica, acontecimientos desmielinizantes centrales y periféricos y notificaciones de lupus, enfermedades relacionadas con lupus y síndrome de Stevens-Johnson.

Población pediátrica

En general, las reacciones adversas en pacientes pediátricos fueron similares en frecuencia y tipo a las observadas en pacientes adultos.

Tabla de reacciones adversas

La siguiente lista de reacciones adversas se basa en la experiencia de ensayos clínicos y en la experiencia postcomercialización y se enumeran según el sistema MedDRA de clasificación por órganos y frecuencia en la tabla 5: muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10); poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100); raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000) y frecuencia no conocida (no pueden estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia. Las frecuencias incluidas son las más altas observadas en las diferentes indicaciones. En los casos en los que se incluye información adicional en las secciones 4.3, 4.4 y 4.7, aparece un asterisco (*) en la columna *Clasificación de órganos del sistema MedDRA*.

Tabla 5. Reacciones Adversas

Clasificación de Órganos del Sistema MedDRA	Frecuencia	Reacciones Adversas
Infecciones e infestaciones*	Muy frecuentes	Infecciones del tracto respiratorio (incluyendo infecciones respiratorias del tracto inferior y superior, neumonía, sinusitis, faringitis, nasofaringitis y neumonía por herpes virus)
	Frecuentes	Infecciones sistémicas (incluyendo sepsis, candidiasis y gripe), Infecciones intestinales (incluyendo gastroenteritis viral), Infecciones de la piel y tejidos blandos (incluyendo paroniquia, celulitis, impétigo, fascitis necrotizante y herpes zoster), Infección de oídos, Infecciones orales (incluyendo herpes simple, herpes oral e infecciones dentales), Infecciones del tracto reproductor (incluyendo infección micótica vulvovaginal), Infecciones del tracto urinario (incluyendo pielonefritis), Infecciones fúngicas, Infecciones de las articulaciones
	Poco frecuentes	Infecciones neurológicas (incluyendo meningitis viral), Infecciones oportunistas y tuberculosis (incluyendo coccidiomicosis, histoplasmosis, infecciones por el complejo mycobacterium avium), Infecciones bacterianas, Infecciones oculares, Diverticulitis[1)]
Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluyendo quistes y pólipos)*	Frecuentes	Cáncer de piel excluido el melanoma (incluyendo carcinoma de células basales y carcinoma de células escamosas), Neoplasia benigna
	Poco frecuentes	Linfoma**, Neoplasia de órganos sólidos (incluyendo cáncer de mama, neoplasia pulmonar y neoplasia tiroidea), Melanoma**
	Raras	Leucemia[1)]

Clasificación de Órganos del Sistema MedDRA	Frecuencia	Reacciones Adversas
	No conocida	Linfoma hepatoesplénico de células T[1)], Carcinoma de células de Merkel (carcinoma neuroendocrino de la piel)[1)] Sarcoma de Kaposi
Trastornos de la sangre y del sistema linfático*	Muy frecuentes	Leucopenia (incluyendo neutropenia y agranulocitosis), Anemia
	Frecuentes	Leucocitosis, Trombocitopenia
	Poco frecuentes	Púrpura trombocitopénica idiopática
	Raras	Pancitopenia
Trastornos del sistema inmunológico*	Frecuentes	Hipersensibilidad, Alergias (incluyendo alergia estacional)
	Poco frecuentes	Sarcoidosis[1)], Vasculitis
	Raras	Anafilaxia[1)]
Trastornos del metabolismo y de la nutrición	Muy frecuentes	Incremento de lípidos
	Frecuentes	Hipopotasemia, Incremento de ácido úrico, Sodio plasmático anormal, Hipocalcemia, Hiperglucemia, Hipofosfatemia, Deshidratación
Trastornos psiquiátricos	Frecuentes	Cambios de humor (incluyendo depresión), Ansiedad, Insomnio
Trastornos del sistema nervioso*	Muy frecuentes	Cefalea
	Frecuentes	Parestesias, (incluyendo hipoestesia), Migraña, Compresión de la raíz nerviosa
	Poco frecuentes	Accidente cerebrovascular[1)], Temblor, Neuropatía
	Raras	Esclerosis múltiple, Trastornos desmielinizantes (p. ej., neuritis óptica, síndrome de Guillain-Barré)[1)]
Trastornos oculares	Frecuentes	Alteración visual, Conjuntivitis, Blefaritis, Hinchazón de ojos
	Poco frecuentes	Diplopía
Trastornos del oído y del laberinto	Frecuentes	Vértigo
	Poco frecuentes	Sordera, Tinnitus
Trastornos cardiacos*	Frecuentes	Taquicardia
	Poco frecuentes	Infarto de miocardio[1)], Arritmia, Insuficiencia cardiaca congestiva
	Raras	Paro cardíaco

Clasificación de Órganos del Sistema MedDRA	Frecuencia	Reacciones Adversas
Trastornos vasculares	Frecuentes	Hipertensión, Rubor, Hematomas
	Poco Frecuentes	Aneurisma aórtico, Oclusión vascular arterial, Tromboflebitis
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos*	Frecuentes	Asma, Disnea, Tos
	Poco frecuentes	Embolia pulmonar[1)], Enfermedad pulmonar intersticial, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Neumonitis, Efusión pleural[1)]
	Raras	Fibrosis pulmonar[1)].
Trastornos gastrointestinales	Muy frecuentes	Dolor abdominal, Náuseas y vómitos
	Frecuentes	Hemorragia gastrointestinal, Dispepsia, Enfermedad de reflujo gastroesofágico, Síndrome del ojo seco
	Poco frecuentes	Pancreatitis, Disfagia, Edema facial
	Raras	Perforación intestinal[1)]
Trastornos hepatobiliares*	Muy frecuentes	Incremento de enzimas hepáticas
	Poco frecuentes	Colecistitis y colelitiasis, Esteatosis hepática, Incremento de la bilirrubina
	Raras	Hepatitis, Reactivación de la hepatitis B[1)], Hepatitis autoinmune[1)]
	No conocida	Fallo hepático[1)]
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo	Muy frecuentes	Erupción (incluyendo erupción exfoliativa)
	Frecuentes	Empeoramiento de la psoriasis existente o psoriasis de nueva aparición (incluyendo psoriasis pustulosa palmo plantar)[1)], Urticaria, Moretones (incluyendo púrpura), Dermatitis (incluyendo eccema), Onicoclasis, Hiperhidrosis, Alopecia[1)], Prurito
	Poco frecuentes	Sudores nocturnos, Cicatrices
	Raras	Eritema multiforme[1)], Síndrome de Stevens-Johnson[1)], Angioedema[1)], Vasculitis cutánea[1)], Reacción liquenoide en la piel[1)]
	No conocida	Empeoramiento de los síntomas de la dermatomiositis[1)]

Clasificación de Órganos del Sistema MedDRA	Frecuencia	Reacciones Adversas
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo	Muy frecuentes	Dolor musculoesquelético
	Frecuentes	Espasmos musculares (incluyendo incrementos plasmáticos de la creatina fosfoquinasa)
	Poco frecuentes	Rabdomiólisis, Lupus eritematoso sistémico
	Raros	Síndrome similar al lupus[1)]
Trastornos renales y urinarios	Frecuentes	Insuficiencia renal, Hematuria
	Poco frecuentes	Nocturia
Trastornos del aparato reproductor y de la mama	Poco frecuentes	Disfunción eréctil
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración*	Muy frecuentes	Reacción en el lugar de inyección (incluyendo eritema en el lugar de inyección)
	Frecuentes	Dolor de pecho, Edema, Pirexia[1)]
	Poco frecuentes	Inflamación
Exploraciones complementarias*	Frecuentes	Alteraciones en la coagulación y el sangrado (incluyendo prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activada), Presencia de autoanticuerpos (incluyendo anticuerpos de ADN bicatenario), Incremento de la lactato deshidrogenasa plasmática
	No conocida	Aumento de peso[2)]
Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones procedimentales	Frecuentes	Alteraciones de la cicatrización

* se incluye información adicional en las secciones 4.3, 4.4 y 4.7

** incluyendo los estudios de extensión abierta

[1)] incluyendo los datos de notificaciones espontáneas

[2)] El cambio medio de peso desde el inicio para adalimumab fue de entre 0,3 kg y 1,0 kg en las indicaciones en adultos en comparación con entre (menos) -0,4 kg y 0,4 kg para el placebo durante un periodo de tratamiento de 4-6 meses. También se ha observado un aumento de peso de 5-6 kg en estudios de extensión a largo plazo con exposiciones medias de aproximadamente 1-2 años sin grupo de control, particularmente en pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. El mecanismo detrás de este efecto no está claro, pero podría estar relacionado con el efecto antiinflamatorio de adalimumab.

Hidradenitis supurativa

El perfil de seguridad de los pacientes con *HS* en tratamiento semanal con adalimumab fue consistente con el perfil de seguridad conocido de adalimumab.

Uveítis

El perfil de seguridad de los pacientes con uveítis en tratamiento con adalimumab en semanas alternas fue consistente con el perfil de seguridad conocido de adalimumab.

Descripción de reacciones adversas seleccionadas

Reacciones en el lugar de inyección

En los ensayos controlados pivotales en adultos y niños, el 12,9% de los pacientes tratados con adalimumab desarrollaron reacciones en el sitio de inyección (eritema y/o picores, hemorragia, dolor o hinchazón), comparado con el 7,2% de los pacientes tratados con placebo o control activo. No se consideró necesario interrumpir el medicamento debido a las reacciones en el lugar de administración.

Infecciones

En los ensayos controlados pivotales en adultos y niños, la incidencia de infecciones fue de 1,51 por paciente/año en los pacientes tratados con adalimumab y 1,46 por paciente/año en los pacientes tratados con placebo y control activo. Las infecciones consistieron fundamentalmente en nasofaringitis, infecciones del tracto respiratorio superior y sinusitis. La mayoría de los pacientes continuaron con adalimumab tras resolverse la infección.

La incidencia de infecciones graves fue de 0,04 por paciente/año en los pacientes tratados con adalimumab y 0,03 por paciente/año en los pacientes tratados con placebo y control activo.

En ensayos controlados abiertos en adultos y pediátricos con adalimumab, se han notificado infecciones graves (incluyendo las mortales, que han ocurrido en casos raros), entre las que se incluyen notificaciones de tuberculosis (incluida la miliar y la localización extrapulmonar) e infecciones oportunistas invasivas (p. ej., histoplasmosis diseminada o extrapulmonar, blastomicosis, coccidiomicosis, pneumocistis, candidiasis, aspergilosis y listeriosis). La mayoría de los casos de tuberculosis tuvieron lugar durante los primeros ocho meses del tratamiento y reflejan la exacerbación de una enfermedad latente.

Enfermedades neoplásicas malignas y trastornos linfoproliferativos

No se han observado enfermedades neoplásicas malignas durante los ensayos con adalimumab en 249 pacientes pediátricos de artritis idiopática juvenil (artritis idiopática juvenil poliarticular y artritis asociada a entesitis) con una exposición de 655,6 pacientes/año. Adicionalmente, no se observaron enfermedades neoplásicas malignas en 192 pacientes pediátricos con una exposición de 498,1 pacientes/año durante un ensayo de adalimumab en pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn. No se han observado enfermedades neoplásicas malignas en 77 pacientes pediátricos con una exposición de 80,0 pacientes/año durante un ensayo de adalimumab en pacientes pediátricos con psoriasis en placa crónica.

Durante las fases controladas de los ensayos clínicos pivotales con adalimumab en adultos que duraron un mínimo de 12 semanas en pacientes con artritis reumatoide activa de moderada a grave, espondilitis anquilosante, espondiloartritis axial sin evidencia radiográfica de EA, artritis psoriásica, psoriasis, hidradenitis supurativa, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa y uveítis, se observaron enfermedades neoplásicas malignas, diferentes a linfoma y cáncer de piel tipo no melanoma, con una incidencia de 6,8 (4,4; 10,5) por 1.000 pacientes/año (intervalo de confianza del 95%) en los 5.291 pacientes tratados con adalimumab, frente a una incidencia de 6,3 (3,4; 11,8) por 1.000 pacientes/año en los 3.444 pacientes del grupo control (la duración media del tratamiento con adalimumab fue de 4,0 meses para los pacientes tratados con adalimumab y de 3,8 meses para los pacientes tratados del grupo control). La incidencia de cáncer de piel tipo no melanoma fue de 8,8 (6,0; 13,0) por 1.000 pacientes/año (intervalo de confianza del 95%) en los pacientes tratados con adalimumab y 3,2 (1,3; 7,6) por 1.000 pacientes/año en los pacientes control. De estos casos de cáncer de piel, el carcinoma de células escamosas se produjo con una incidencia de 2,7 (1,4; 5,4) por 1.000 pacientes/año (intervalo de confianza del 95%) en los pacientes tratados con adalimumab y de un 0,6 (0,1; 4,5) por 1.000 pacientes/año en los pacientes del grupo control. La incidencia de linfomas fue de 0,7 (0,2; 2,7) por 1.000 pacientes/año (intervalo de confianza del 95%) entre los pacientes tratados con adalimumab y de 0,6 (0,1; 4,5) por 1.000 pacientes/año en los pacientes del grupo control.

Cuando se combinan los datos obtenidos en las fases controladas de estos ensayos clínicos de adalimumab y los ensayos de extensión abiertos en curso y completados, con una duración media aproximada de 3,3 años que incluyen 6.427 pacientes y más de 26.439 pacientes/año de tratamiento, la incidencia observada de enfermedades neoplásicas malignas, excluyendo linfomas y cáncer de piel (tipo no melanoma), es de aproximadamente 8,5 por 1.000 pacientes/año. La incidencia observada de cáncer de piel (tipo no melanoma) es de aproximadamente un 9,6 por 1.000 pacientes/año. La incidencia observada de linfomas es de aproximadamente 1,3 por 1.000 pacientes/año.

En la experiencia postcomercialización desde enero de 2003 a diciembre de 2010, principalmente en pacientes con artritis reumatoide, la incidencia registrada de enfermedades neoplásicas malignas es aproximadamente de 2,7 por 1.000 pacientes tratados/año. La frecuencia registrada para cáncer de piel (tipo no melanoma) y linfomas es de aproximadamente 0,2 y 0,3 por 1.000 pacientes tratados/año, respectivamente (ver sección 4.4).

Durante la comercialización se han notificado casos raros de linfoma hepatoesplénico de células T en pacientes tratados con adalimumab (ver sección 4.4).

Autoanticuerpos

Se analizaron muestras séricas a distintos tiempos de los pacientes para la detección de autoanticuerpos en los ensayos I-V de artritis reumatoide. En dichos ensayos, el 11,9% de los pacientes tratados con adalimumab y el 8,1% de los pacientes tratados con placebo y control activo que tuvieron títulos de anticuerpos antinucleares basales negativos dieron títulos positivos en la semana 24. Dos pacientes de los 3.441 tratados con adalimumab en todos los ensayos de artritis reumatoide y artritis psoriásica desarrollaron signos clínicos que sugerían un síndrome tipo lupus de reciente aparición. Los pacientes mejoraron tras interrumpir el tratamiento. Ningún paciente desarrolló lupus, nefritis o síntomas a nivel del sistema nervioso central.

Efectos hepatobiliares

En los ensayos clínicos controlados fase 3 de adalimumab en pacientes con artritis reumatoide y artritis psoriásica con un rango de duración del periodo de control de 4 a 104 semanas, se produjo un aumento de ALT ≥ 3 × SLN en un 3,7% de los pacientes tratados con adalimumab y en un 1,6% de los pacientes del grupo control.

En los ensayos clínicos controlados fase 3 de adalimumab en pacientes de 4 a 17 años con artritis idiopática juvenil poliarticular y en pacientes de 6 a 17 años con artritis asociada a entesitis, se produjo un aumento de ALT ≥ 3 × SLN en un 6,1% de los pacientes tratados con adalimumab y en un 1,3% de los pacientes del grupo control. La mayoría de los aumentos de ALT se produjeron con el uso en combinación con metotrexato. No se produjeron aumentos de la ALT ≥ 3 × SLN en los ensayos de Fase 3 de adalimumab en pacientes con artritis idiopática juvenil poliarticular de 2 a < 4 años de edad.

En los ensayos clínicos controlados fase 3 de adalimumab en pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa con un rango de duración del periodo de control de 4 a 52 semanas, se produjo un aumento de ALT ≥ 3 × SLN en un 0,9% de los pacientes tratados con adalimumab y en un 0,9% de los pacientes del grupo control.

En los ensayos fase 3 de adalimumab en pacientes con enfermedad de Crohn pediátrica en los que se evaluó la eficacia y la seguridad de dos regímenes de dosificación ajustados por peso corporal en mantenimiento tras un tratamiento de inducción ajustado por peso corporal hasta 52 semanas de tratamiento, se observaron aumentos de la ALT ≥ 3 × SLN sobre el límite normal en el 2,6% (5/192) de los pacientes, 4 de los cuales recibieron inmunosupresores concomitantes inicialmente.

En los ensayos clínicos controlados fase 3 de adalimumab en pacientes con psoriasis en placas con un rango de duración del periodo de control de 12 a 24 semanas, se produjo un aumento de ALT ≥ 3 × SLN en un 1,8% de los pacientes tratados con adalimumab y en un 1,8% de los pacientes del grupo control.

No se produjeron aumentos de ALT ≥ 3 × SLN en los ensayos clínicos fase 3 de adalimumab en pacientes pediátricos con psoriasis en placas.

En ensayos controlados con adalimumab (dosis inicial de 160 mg en la semana 0 y 80 mg en la semana 2, seguido de 40 mg semanales a partir de la semana 4), se produjeron aumentos de ALT ≥ 3 × SLN en un 0,3% de los pacientes tratados con adalimumab y un 0,6% de los pacientes del grupo control, en pacientes con hidradenitis supurativa con una duración del periodo control de 12 a 16 semanas.

En los ensayos clínicos controlados con adalimumab (dosis inicial de 80 mg en la semana 0 seguido de 40 mg en semanas alternas comenzando en la semana 1) en pacientes adultos con uveítis hasta 80 semanas con una exposición media de 166,5 días y 105,0 días para pacientes en tratamiento con adalimumab y pacientes control respectivamente, se produjeron aumentos de ALT ≥ 3 × SLN en un 2,4% de los pacientes en tratamiento con adalimumab y en un 2,4% en los pacientes control.

En los ensayos clínicos de todas las indicaciones, los pacientes con ALT elevada fueron asintomáticos y en la mayoría de los casos estos aumentos fueron transitorios y se resolvieron en el curso del tratamiento. Sin embargo, en pacientes que han recibido adalimumab, se han notificado además casos de fallo hepático, así como afecciones hepáticas menos graves que pueden preceder a la insuficiencia hepática, tales como hepatitis, incluida la hepatitis autoinmune, en el periodo de postcomercialización.

Tratamiento concomitante con azatioprina/6-mercaptopurina

En estudios de enfermedad de Crohn con pacientes adultos, se vieron mayores incidencias de neoplasias malignas y efectos adversos relacionados con infecciones graves con la combinación de adalimumab y azatioprina/6-mercaptopurina comparado con adalimumab solo.

4.8 Sobredosis

No se observó toxicidad limitante de la dosis durante los ensayos clínicos en pacientes. El nivel de dosis más alto evaluado ha sido la administración intravenosa repetida de dosis de 10 mg/kg, que supone aproximadamente 15 veces la dosis recomendada.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propiedades Farmacodinámicas

Grupo farmacoterapéutico: Inmunosupresores, inhibidores del Factor de Necrosis Tumoral alfa (*TNF*-α).
Código ATC: L04AB04

Mecanismo de acción

Adalimumab se une específicamente al *TNF* (Factor de necrosis tumoral) y neutraliza su función biológica al bloquear su interacción con los receptores p55 y p75 del *TNF* en la superficie celular.

Adalimumab también modula la respuesta biológica inducida o regulada por el *TNF*, incluyendo cambios en los niveles de las moléculas de adhesión responsables de la migración leucocitaria (*ELAM*-1, *VCAM*-1, e *ICAM*-1 con una CI_{50} de 0,1-0,2 nM).

Efectos farmacodinámicos

Tras el tratamiento con adalimumab, se observó una rápida disminución de los niveles de los componentes de fase aguda de inflamación (proteína C reactiva, PCR) y velocidad de sedimentación globular (VSG) y de las citoquinas plasmáticas (IL-6) en comparación con el inicial en pacientes con artritis reumatoide. Los niveles plasmáticos de metaloproteinasas de la matriz (MMP-1 y MMP-3) que

participan en la remodelación tisular responsable de la destrucción del cartílago también disminuyeron tras la administración de adalimumab. Los pacientes tratados con adalimumab generalmente experimentaron mejorías en los signos hematológicos de inflamación crónica.

En pacientes con artritis idiopática juvenil poliarticular, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa e hidradenitis supurativa se ha observado un rápido descenso en los niveles de Proteína C reactiva (PCR), después del tratamiento con adalimumab. En pacientes con enfermedad de Crohn se observó una reducción en el número de células que expresan marcadores inflamatorios en el colon, incluyendo una reducción significativa en la expresión del *TNFα*. Los estudios endoscópicos de la mucosa intestinal han mostrado evidencias de cicatrización de mucosa en pacientes tratados con adalimumab.

Datos de eficacia clínica

Estudio comparativo de artritis reumatoide (AR) entre AMGEVITA y Adalimumab (Humira) (Estudio 1- AR AMGEVITA (ABP501)):

La eficacia y seguridad de AMGEVITA en comparación con adalimumab se evaluaron en un estudio aleatorizado de control activo, doble ciego en pacientes ≥ 18 años de edad con artritis reumatoide activa diagnosticada según los criterios del Colegio Americano de Reumatología (*ACR*, por sus siglas en inglés) 2010 / Liga Europea contra el Reumatismo (*EULAR*, por sus siglas en inglés). Los pacientes tenían AR por al menos 3 meses de duración y al menos 6 articulaciones inflamadas y 6 dolorosas y alta VSG o PCR al ingreso al estudio. Los pacientes tenían factor reumatoide o positividad de antipéptido citrulinado cíclico. El estudio evaluó a 526 pacientes que tuvieron una respuesta inadecuada al MTX (Metotrexato) a dosis de 7,5 a 25 mg. Los pacientes recibieron 40 mg de AMGEVITA o adalimumab por vía subcutánea cada dos semanas durante hasta 22 semanas.

Respuesta clínica

El porcentaje de sujetos tratados con AMGEVITA que lograron *ACR* 20 en la semana 24 en el Estudio 1- AR AMGEVITA (ABP501) se muestra en la Tabla 6. La razón de riesgo (RR) del criterio de valoración primario *ACR* 20 estaba dentro del margen de equivalencia preespecificado y mostró equivalencia clínica entre AMGEVITA y adalimumab PR (producto de referencia).

Tabla 6. Respuestas clínicas en Estudio 1- AR AMGEVITA (ABP501) (porcentaje de pacientes)

	AMGEVITA (24 semanas)	**Adalimumab PR (24 semanas)**
ACR 20	74,6%	72,4%

En la semana 24, el 74,6% (194/260) de los sujetos en el grupo AMGEVITA y el 72,4% (189/261) de los sujetos en el grupo adalimumab cumplieron con los criterios de respuesta *ACR* 20. La RR de *ACR* 20 para AMGEVITA versus adalimumab fue de 1,039 con un intervalo de confianza (IC) del 90% a 2 colas de (0,954, 1,133). El IC del 90% cayó dentro del margen de equivalencia predefinido. La diferencia de riesgo (*RD*, por sus siglas en inglés) de *ACR* 20 para AMGEVITA versus adalimumab fue 2,604% con el intervalo de confianza (IC) del 90% a 2 colas de (-3,728%, 8,936%). Por lo tanto, se demostró la equivalencia clínica entre AMGEVITA y adalimumab.

Los resultados de los componentes de los criterios de respuesta *ACR* para el Estudio 1- AR AMGEVITA (ABP501) se muestran en la tabla 7. Las tasas de respuesta *ACR* y la mejora en todos los componentes de la respuesta *ACR* mostraron una ausencia de diferencias clínicamente significativas entre los dos grupos en la semana 24.

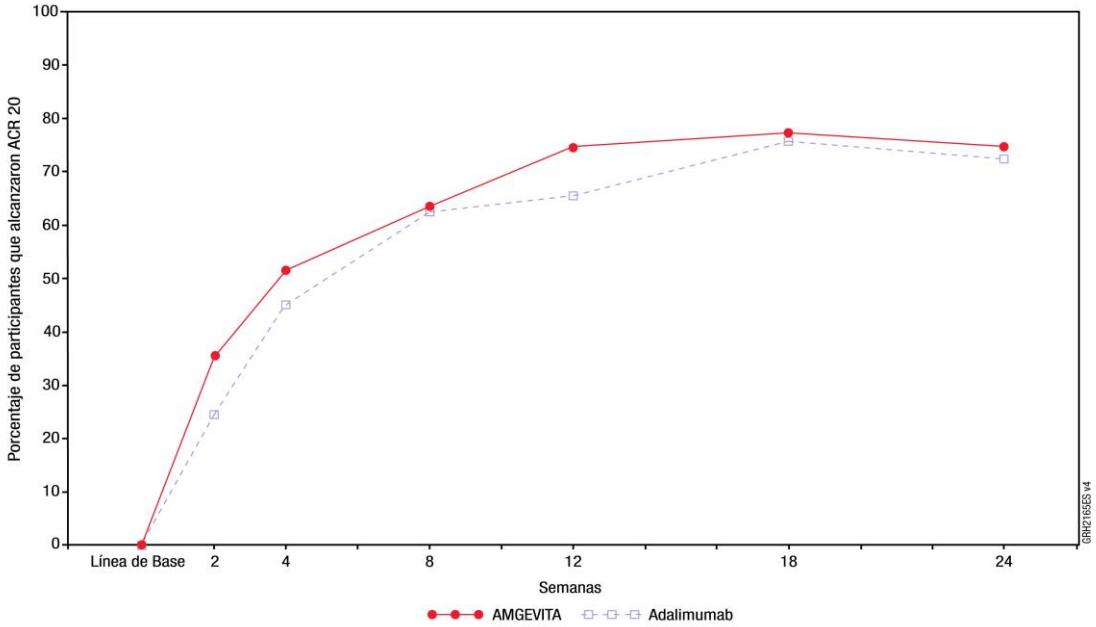
Tabla 7. Componentes de la respuesta *ACR*

Parámetro (media)	AMGEVITA[a] N = 264		Adalimumab[a] N = 262	
	Línea base	Semana 24	Línea base	Semana 24
Número de articulaciones dolorosas (0-68)	21,0	4,0	20,5	4,0
Número de articulaciones inflamadas (0-66)	12,0	2,0	12,0	2,0
Evaluación global del médico[b]	7,0	2,0	7,0	2,0
Evaluación global del paciente[b]	7,0	3,0	7,0	3,0
Dolor[c]	60,0	19,0	65,0	21,0
Índice de discapacidad (*HAQ*)[d]	1,5	1,0	1,5	0,9
PCR (mg/L)	6,1	3,0	7,6	3,0

[a] 40 mg administrado cada dos semanas
[b] Escala análoga visual; 0 = mejor, 10 = peor
[c] Escala de dolor; 0 = sin dolor; 100 = dolor intenso
[d] Índice de discapacidad del cuestionario de evaluación de salud; 0 = mejor, 3 = peor, mide la capacidad del paciente para realizar lo siguiente: vestirse/arreglarse, levantarse, comer, caminar, alcanzar, agarrar, mantener la higiene y mantener la actividad diaria

El curso temporal de la respuesta *ACR* 20 se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Estudio 1 en AR AMGEVITA (ABP501) con porcentaje de respuesta para AMGEVITA y Adalimumab *ACR* 20 durante 24 semanas



Estudio comparativo de psoriasis en placa (*Ps*) entre AMGEVITA y Adalimumab (Humira) (Estudio 1- *Ps* AMGEVITA (ABP501))

La eficacia y la seguridad de AMGEVITA se evaluaron en un estudio aleatorizado, de control activo, doble ciego en 350 pacientes ≥ 18 años de edad con psoriasis en placa moderada a severa (*Ps*) que

fueron candidatos para terapia sistémica o fototerapia. Los pacientes tenían Ps en placa moderada a severa estable durante al menos 6 meses, un área de superficie corporal (ASC) ≥ 10% y un Área de Psoriasis e Índice de Severidad (*PASI*) ≥ 12 al ingreso al estudio. Los pacientes recibieron AMGEVITA o adalimumab en una dosis de carga inicial de 80 mg administrados por vía SC en la semana 1/día 1, seguido de 40 mg SC administrados cada dos semanas comenzando una semana después de la dosis de carga. El porcentaje de mejoría de *PASI* desde el inicio se midió y comparó con adalimumab (ver tabla 8) y se encontró dentro del margen de equivalencia preespecificado para demostrar la equivalencia clínica entre AMGEVITA y adalimumab.

Tabla 8. Resultados de eficacia a la semana 16 en el Estudio 1- *Ps* AMGEVITA (ABP501)

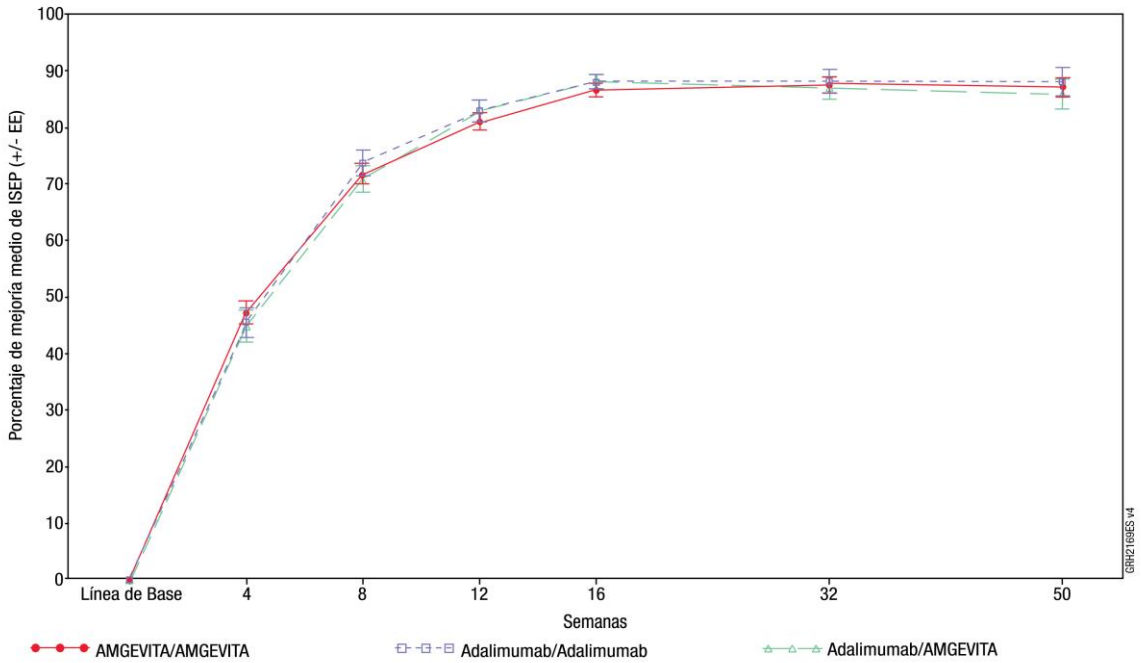
	AMGEVITA N = 175	**Adalimumab N = 175**
PASI % Mejora desde la línea base	80,91	83,06

El desenlace primario fue el porcentaje de mejoría del *PASI* desde la línea base hasta la semana 16. En la semana 16, el porcentaje de mejoría del *PASI* desde la línea base fue 80,9 en el grupo AMGEVITA y 83,1 en el grupo adalimumab. La diferencia media de mínimos cuadrados (*LS*, por sus siglas en inglés) de la mejora del porcentaje de *PASI* desde el inicio hasta la semana 16 entre AMGEVITA y adalimumab fue de -2,18 con un IC del 95% a 2 colas (-7,39, 3,02). El IC del 95% estaba dentro del margen de equivalencia predefinido, lo que demuestra la equivalencia clínica de AMGEVITA y adalimumab.

Después de que los sujetos con una respuesta 50 (*PASI* mejora del 50% o mayor) se volvieron a aleatorizar en la semana 16 para continuar en el estudio, se observaron resultados similares en la semana 50 (final del estudio), donde la mejora del porcentaje de *PASI* promedio desde el inicio fue similar en todos los grupos de tratamiento: AMGEVITA/AMGEVITA fue 87,16; adalimumab/adalimumab fue 88,11, y adalimumab/AMGEVITA fue 85,82.

En la Figura 2 se muestra la mejoría media del porcentaje de *PASI* desde el inicio durante la duración del estudio.

Figura 2. Mejora del porcentaje promedio de *PASI* desde la línea base durante la duración del Estudio 1- *Ps* AMGEVITA (ABP501)



Inmunogenicidad

Las diferencias en la metodología de ensayo, para medir la inmunogenicidad evitan la comparación directa de las tasas de inmunogenicidad entre AMGEVITA y adalimumab u otros productos biológicos en diferentes estudios. En el Estudio 1 AR AMGEVITA (ABP501) y Estudio 1 *Ps* AMGEVITA (ABP501), la actividad de unión del anticuerpo antidrogas (*ADA*) se determinó utilizando un inmunoensayo puente y la actividad neutralizante de *ADA* se determinó utilizando un bioensayo basado en células.

Datos de artritis reumatoide (AR)

Los pacientes en el Estudio 1 AR-AMGEVITA (ABP501) fueron evaluados en múltiples puntos temporales para detectar anticuerpos contra adalimumab y AMGEVITA durante el período de estudio de 26 semanas. La incidencia de presentación de anticuerpos de unión fue del 38,3% (101/264) en el grupo AMGEVITA y del 38,2% (100/262) en el grupo adalimumab; la incidencia de presentación de anticuerpos neutralizantes fue del 9,1% (24/264) en el grupo AMGEVITA y del 11,1% (29/262) en el grupo adalimumab. Con base en los datos del Estudio 1 AR-AMGEVITA (ABP501), se encontró que el perfil de inmunogenicidad de AMGEVITA era similar al adalimumab PR.

Datos de psoriasis (*Ps*)

Los pacientes en el Estudio 1- *Ps* AMGEVITA (ABP501) fueron evaluados en múltiples puntos de tiempo para detectar anticuerpos contra adalimumab y AMGEVITA durante el período de estudio de 52 semanas. La incidencia de presentación de anticuerpos de unión a lo largo de todo el estudio fue del 68,4% (104/152) en el grupo AMGEVITA/AMGEVITA, 74,7% (59/79) en el grupo adalimumab/adalimumab y 72,7% (56/77) en el grupo adalimumab/AMGEVITA; la incidencia de presentación de anticuerpos neutralizantes fue del 13,8% (21/152) en el grupo AMGEVITA/AMGEVITA, 20,3% (16/79) en el grupo adalimumab/adalimumab y 24,7% (19/77) en el grupo adalimumab/AMGEVITA. El grupo adalimumab/AMGEVITA refleja los datos de sujetos expuestos a adalimumab y AMGEVITA antes y después de la transición de los sujetos adalimumab a AMGEVITA. Los perfiles de seguridad e inmunogenicidad de los pacientes que pasaron de adalimumab a AMGEVITA fueron comparables a los que continuaron con adalimumab hasta el final del estudio (semana 52).

5.2 Propiedades Farmacocinéticas

AMGEVITA es farmacocinéticamente similar a Humira.

Absorción y distribución

La absorción y distribución de adalimumab tras la administración subcutánea de una dosis única de 40 mg, fue lenta, alcanzándose las concentraciones plasmáticas máximas a los 5 días después de la administración. La media de biodisponibilidad absoluta de adalimumab fue del 64%, estimada a partir de tres ensayos con una dosis subcutánea única de 40 mg. Tras la administración intravenosa de dosis únicas en un rango de 0,25 a 10 mg/kg, las concentraciones fueron proporcionales a la dosis. Tras la administración de dosis de 0,5 mg/kg (~40 mg), el aclaramiento osciló en el rango de 11 a 15 mL/hora, el volumen de distribución (V_{ss}) entre 5 y 6 litros, y la semivida media de eliminación terminal fue aproximadamente dos semanas. Las concentraciones de adalimumab en el líquido sinovial, determinadas en varios pacientes con artritis reumatoide, oscilaron entre el 31 y el 96% de las concentraciones plasmáticas.

Tras la administración subcutánea de 40 mg de adalimumab en semanas alternas en pacientes adultos con artritis reumatoide (AR), la media de las concentraciones en el punto mínimo en el estado estacionario fue aproximadamente 5 µg/mL (sin tratamiento concomitante con metotrexato) y 8 a 9 µg/mL (con metotrexato concomitante), respectivamente. Los niveles plasmáticos de adalimumab

en el estado estacionario aumentaron más o menos proporcionalmente con la dosis tras la administración subcutánea de 20, 40 y 80 mg en semanas alternas y cada semana.

Tras la administración subcutánea en semanas alternas de 24 mg/m^2 (máximo de 40 mg) en pacientes con artritis idiopática juvenil poliarticular (*JIA*), que tenían entre 4 y 17 años, la concentración plasmática media de adalimumab en estado estacionario (valores medidos de la semana 20 a la 48) fue 5,6 ± 5,6 µg/mL (102% *CV*) con adalimumab sin metotrexato concomitante y 10,9 ± 5,2 µg/mL (47,7% *CV*) con metotrexato concomitante.

En pacientes con *JIA* poliarticular que tenían de 2 a < 4 años o con 4 años y un peso inferior a 15 kg dosificados con 24 mg/m^2 de adalimumab, la concentración plasmática media de adalimumab en estado estacionario fue 6,0 ± 6,1 µg/mL (101% *CV*) para adalimumab sin metotrexato concomitante y 7,9 ± 5,6 µg/mL (71,2% *CV*) con metotrexato concomitante.

Tras la administración de 24 mg/m^2 (máximo de 40 mg) por vía subcutánea en semanas alternas en pacientes de 6 a 17 años con artritis asociada a entesitis, la concentración media de adalimumab en estado estacionario (valores medidos en la semana 24) fue de 8,8 ± 6,6 µg/mL para adalimumab sin metotrexato concomitante y 11,8 ± 4,3 µg/mL con metotrexato concomitante.

Tras la administración subcutánea de 40 mg de adalimumab cada dos semanas en pacientes adultos con espondiloartritis axial no radiográfica, la concentración media (± *SD*) en el estado estacionario en la semana 68 fue de 8,0 ± 4,6 µg/mL.

En pacientes adultos con psoriasis, la media de la concentración en el punto mínimo en el estado estacionario fue de 5 µg/mL durante el tratamiento en monoterapia con adalimumab 40 mg en semanas alternas.

Tras la administración subcutánea de 0,8 mg/kg (máximo de 40 mg) en semanas alternas a pacientes pediátricos con psoriasis en placas crónica, la media ± *SD* de las concentraciones de adalimumab en el punto mínimo del estado estacionario fue 7,4 ± 5,8 µg/mL (79% CV).

En pacientes adultos con hidradenitis supurativa, con una dosis de 160 mg de adalimumab en la semana 0 seguido de 80 mg en la semana 2 se alcanzaron concentraciones séricas mínimas de adalimumab de aproximadamente 7 a 8 µg/mL en la semana 2 y la semana 4. La concentración media en el estado estacionario en la semana 12 hasta la semana 36 fue aproximadamente de 8 a 10 µg/mL durante el tratamiento con adalimumab 40 mg semanal.

En pacientes con enfermedad de Crohn, con la dosis de carga de 80 mg de adalimumab en la semana 0, seguida de 40 mg de adalimumab en la semana 2, se alcanzaron concentraciones plasmáticas de adalimumab de aproximadamente 5,5 µg/mL durante el periodo de inducción. Con la dosis de carga de 160 mg de adalimumab en la semana 0, seguida de 80 mg de adalimumab en la semana 2, se alcanzaron concentraciones plasmáticas de adalimumab de aproximadamente 12 µg/mL durante el periodo de inducción. Se observaron niveles medios en el punto mínimo en el estado estacionario de aproximadamente 7 µg/mL en pacientes con enfermedad de Crohn que recibieron una dosis de mantenimiento de 40 mg de adalimumab en semanas alternas.

En pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn de moderada a grave, la dosis de inducción con adalimumab fue de 160/80 mg o 80/40 mg en las semanas 0 y 2, respectivamente, dependiendo de un corte de 40 kg de peso corporal. En la semana 4, los pacientes fueron aleatorizados 1:1 en grupos de tratamiento de mantenimiento según su peso corporal a la dosis estándar (40/20 mg en semanas alternas) o dosis baja (20/10 mg en semanas alternas). La media (± *SD*) de la concentración sérica valle de adalimumab alcanzada en la semana 4 fue 15,7 ± 6,6 µg/mL para pacientes ≥ 40 kg (160/80 mg) y 10,6 ± 6,1 µg/mL para pacientes < 40 kg (80/40 mg).

Para aquellos pacientes que permanecieron en el tratamiento aleatorizado, la media (± *SD*) de la concentración valle de adalimumab en la semana 52 fue de 9,5 ± 5,6 µg/mL para el grupo de la dosis estándar y 3,5 ± 2,2 µg/mL para el grupo de dosis bajas. Se mantuvo la media de las concentraciones valle en los sujetos que continuaron el tratamiento con adalimumab en semanas alternas durante

52 semanas. Para aquellos pacientes en los que se produjo una escalada de dosis del régimen de semanas alternas a semanalmente, la media (± *SD*) de las concentraciones séricas de adalimumab en la semana 52 fueron 15,3 ± 11,4 µg/mL (40/20 mg semanalmente) y 6,7 ± 3,5 µg/mL (20/10 mg semanalmente).

En pacientes con colitis ulcerativa, con la dosis de carga de 160 mg de adalimumab en la semana 0, seguida de 80 mg de adalimumab en la semana 2 se alcanzaron concentraciones plasmáticas de adalimumab de aproximadamente 12 µg/mL durante el periodo de inducción. Se observaron niveles medios en el punto mínimo en el estado estacionario de 8 µg/mL en pacientes con colitis ulcerativa que recibieron una dosis de mantenimiento de 40 mg de adalimumab en semanas alternas.

En pacientes adultos con uveítis, una dosis de carga de 80 mg de adalimumab en la semana 0 seguida de 40 mg de adalimumab en semanas alternas comenzando en la semana 1, permitió alcanzar concentraciones medias en el estado estacionario de aproximadamente 8 a 10 µg/mL.

La modelización y simulación de la farmacocinética/farmacodinámica y la farmacocinética de la población predijo una exposición a adalimumab y eficacia similar en pacientes tratados con 80 mg cada dos semanas comparado con 40 mg semanal (incluyendo pacientes adultos con AR, HS, CU, EC o *Ps*, y pacientes pediátricos ≥ 40 kg con EC).

Relación exposición-respuesta en población pediátrica

Basándose en los datos de ensayos clínicos en pacientes con *JIA* (*pJIA* y ARE) se estableció una relación exposición-respuesta entre las concentraciones plasmáticas y la respuesta *PedACR* 50. La concentración plasmática aparente de adalimumab que produce la mitad del máximo de probabilidad de respuesta *PedACR* 50 (EC_{50}) fue 3 µg/mL (IC del 95%: 1-6 µg/mL).

Las relaciones exposición-respuesta entre la concentración de adalimumab y la eficacia en pacientes pediátricos con placas psoriásicas crónicas graves se establecieron por *PASI* 75 y *PGA* sin lesiones o mínimas, respectivamente. *PASI* 75 y *PGA* sin lesiones o mínimas aumentó con el aumento de las concentraciones de adalimumab ambas con un EC_{50} aparente de aproximadamente 4,5 µg/mL (IC del 95% 0,4-47,6 y 1,9-10,5, respectivamente).

Eliminación

Los análisis farmacocinéticos poblacionales con datos de aproximadamente 1.300 pacientes con AR revelaron una tendencia a una correlación directa entre el incremento aparente del aclaramiento de adalimumab y el peso corporal. Después de un ajuste según las diferencias de peso corporal, se observó que el efecto del sexo y la edad sobre el aclaramiento de adalimumab era mínimo. Los niveles plasmáticos de adalimumab libre (no unido a anticuerpos anti-adalimumab, AAA) se observó que eran inferiores en pacientes con AAA cuantificables.

Insuficiencia renal o hepática

Adalimumab no se ha estudiado en pacientes con insuficiencia hepática o renal.

5.3 Datos Preclínicos Sobre Seguridad

Los datos de los estudios no clínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según los estudios convencionales de toxicidad a dosis única, a dosis repetidas y genotoxicidad.

Se ha llevado a cabo un estudio de toxicidad en el desarrollo embrio-fetal/perinatal en monos *Cynomolgus* con dosis de 0,30 y 100 mg/kg (9-17 monos/grupo) que no ha revelado evidencia de daños fetales debidos a adalimumab. No se llevaron a cabo ni estudios de carcinogénesis ni de evaluación estándar de la fertilidad y de la toxicidad postnatal con adalimumab debido a la falta de modelos apropiados para estudiar un anticuerpo con reactividad cruzada limitada al *TNF* del roedor y al desarrollo de anticuerpos neutralizantes en roedores.

6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1 Lista de Excipientes

Sacarosa
Polisorbato 80
Ácido acético glacial
Hidróxido de sodio
Agua para inyección

6.2 Incompatibilidades

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros.

6.3 Precauciones Especiales de Almacenamiento

Conservar en nevera (2°C – 8°C).
No congelar.
Conservar AMGEVITA dentro del empaque para protegerlo de la luz.

La jeringa prellenada o un autoinyector prellenado se puede almacenar a una temperatura máxima de 30°C durante un periodo de hasta 7 días. La jeringa prellenada o el autoinyector prellenado deben protegerse de la luz y desecharse en caso de no utilizarse dentro de un periodo de 7 días.

6.4 Naturaleza y Contenido del Envase

AMGEVITA 20 mg solución inyectable en jeringa prellenada
0,4 mL de solución en jeringa prellenada (vidrio tipo I).

AMGEVITA 40 mg solución inyectable en jeringa prellenada
0,8 mL de solución en jeringa prellenada (vidrio tipo I).

AMGEVITA 40 mg solución inyectable en autoinyector prellenado (Sureclick®)
0,8 mL de solución inyectable en autoinyector para uso del paciente que contiene una jeringa prellenada (vidrio tipo I). El autoinyector es de un solo uso, un dispositivo manual, inyectable, mecánico, desechable. El capuchón de la aguja del autoinyector prellenado está fabricado con caucho natural (un derivado del látex) (ver sección 4.4).

6.5 Instrucciones Especiales de Uso y Manipulación

6.5.1 Instrucciones de Uso para la Jeringa Prellenada de AMGEVITA

Instrucciones de Uso: AMGEVITA jeringa prellenada de un solo uso Vía subcutánea

Guía de componentes	
Antes de usar	**Después de usar**
Émbolo Aletas de sujeción Etiqueta y fecha de vencimiento Cuerpo de la jeringa Medicamento Cubierta de la aguja colocada	Émbolo usado Aletas de sujeción Etiqueta y fecha de vencimiento Cuerpo de la jeringa usado Aguja usada Cubierta de la aguja retirada
Importante: La aguja está en el interior	

Importante

Antes de utilizar una jeringa prellenada de AMGEVITA, lea esta información importante:

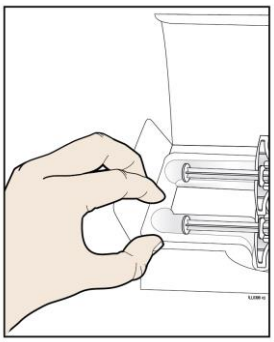
Utilización de la jeringa prellenada de AMGEVITA

- Es importante que no intente autoadministrarse la inyección a menos que usted o su cuidador hayan recibido capacitación.
- **No** utilice la jeringa prellenada de AMGEVITA si ha caído sobre una superficie dura. Es posible que algún componente de la jeringa prellenada de AMGEVITA esté roto, incluso si usted no lo nota. Utilice una nueva jeringa prellenada de AMGEVITA.

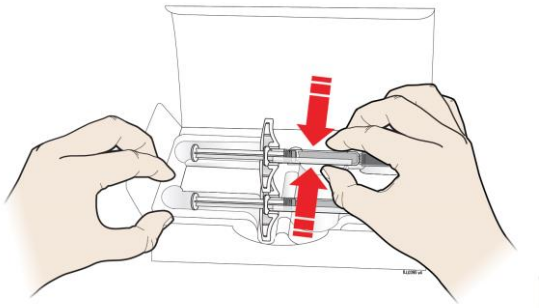
Paso 1: Preparación

A. Saque del empaque la cantidad de jeringas prellenadas de AMGEVITA que necesite.

Sujete la jeringa por el cuerpo de la jeringa para sacarla de la bandeja.



Coloque uno de sus dedos en el borde de la bandeja para asegurarlo cuando retire la jeringa.



Sujete aquí

Vuelva a colocar el empaque original con las jeringas no utilizadas en el refrigerador.

Por motivos de seguridad:

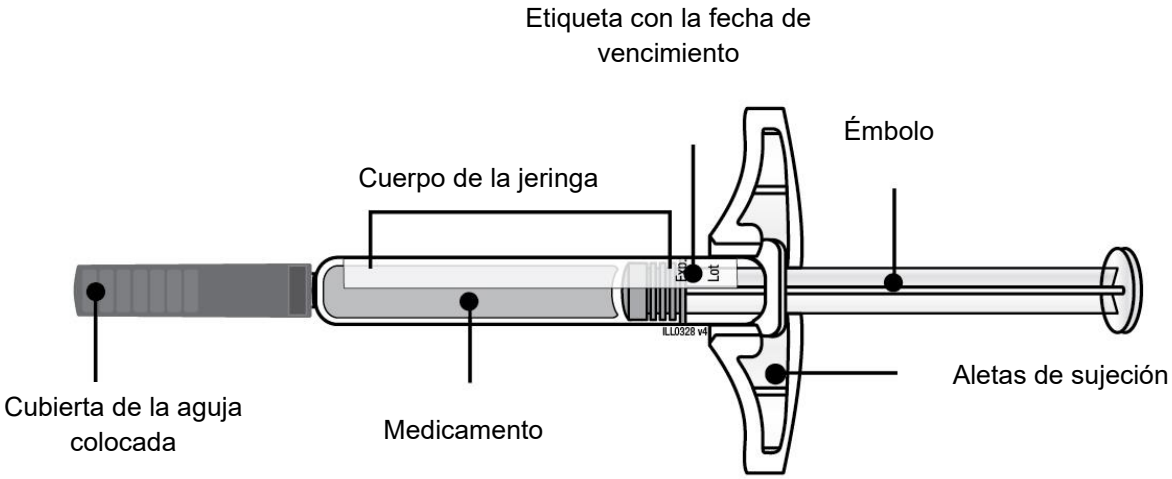
- **No** sujete la jeringa por el émbolo.
- **No** sujete la jeringa por la cubierta de la aguja.
- **No** retire la cubierta de la aguja hasta estar listo para la inyección.
- **No** retire las aletas de sujeción. Son parte de la jeringa.

Para una administración más cómoda de la inyección, deje la jeringa a temperatura ambiente entre **15 a 30** minutos antes de realizar la aplicación.

- **No** vuelva a guardar la jeringa en el refrigerador una vez haya alcanzado temperatura ambiente.
- **No** intente calentar la jeringa utilizando fuentes de calor como agua caliente o el microondas.
- **No** deje la jeringa expuesta a la luz directa del sol.
- **No** agite la jeringa.

Importante: Sostenga siempre la jeringa prellenada, por el cuerpo de la jeringa.

B. Revise la jeringa prellenada de AMGEVITA.



Siempre sujete la jeringa prellenada por el cuerpo de la jeringa.

Asegúrese de que el medicamento contenido en la jeringa sea claro e incoloro a ligeramente amarillo.

- **No** utilice la jeringa si:
  - El medicamento luce turbio, presenta cambio de color o contiene copos o partículas.
  - Alguno de sus componentes parece estar agrietado o roto.
  - Si la cubierta de la aguja no está o está suelta.
  - Ha expirado la fecha de vencimiento impresa en la etiqueta.

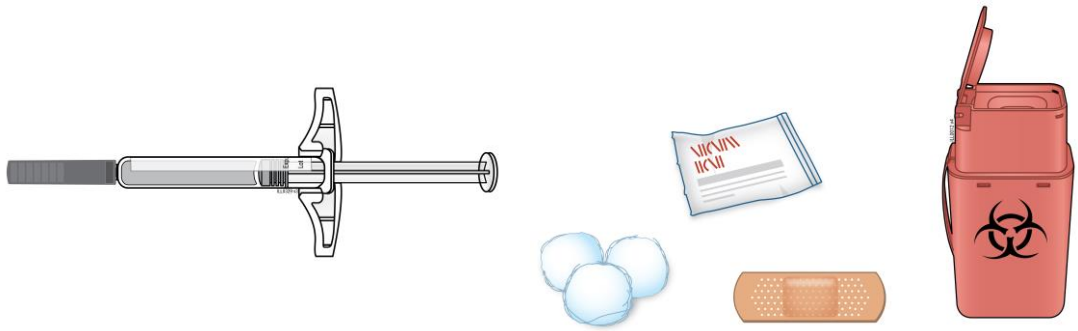
En cualquiera de estos casos, utilice una nueva jeringa.

C. Reúna los implementos que necesita para la (s) inyección(es).

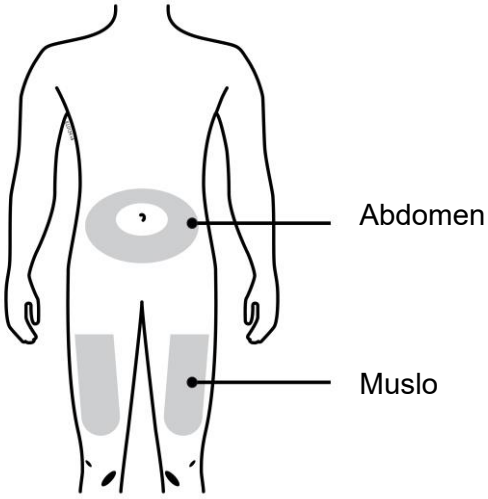
Lave sus manos adecuadamente con agua y jabón.
Sobre una superficie de trabajo limpia y bien iluminada, coloque una jeringa prellenada nueva.

Además, necesitará estos ítems adicionales, ya que no están incluidos en el empaque:

- Pañito impregnado de alcohol
- Bolas de algodón o trozos de gasa
- Una curita
- Recipiente para desechar objetos cortopunzantes



D Prepare y limpie el (los) sitio(s) de inyección.

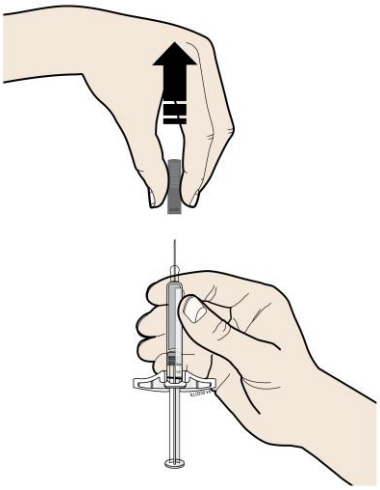


Puede utilizar:
- El muslo
- Abdomen, excepto la zona de 2 pulgadas (**5** centímetros) alrededor del ombligo.

Limpie el área de inyección con un pañito impregnado de alcohol. Deje secar la piel.
- **No** toque de nuevo esa área antes de aplicar la inyección.
- Si desea utilizar la misma área de inyección, asegúrese de no utilizar el mismo punto que utilizó en la inyección anterior.
  - **No** aplique la inyección en áreas con la piel sensible al tacto, con moretones, enrojecida o endurecida. Evite aplicar la inyección en áreas donde existan cicatrices o estrías.
- Si sufre de psoriasis, debe evitar inyectarse directamente en parches o lesiones de piel levantada, gruesa o escamada.

Paso 2: Alistamiento

E. Cuando esté listo para la inyección, hale la cubierta de la aguja en línea recta, lejos de su cuerpo.

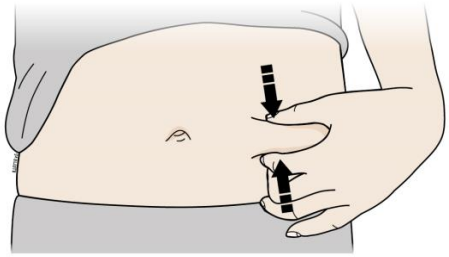


Es normal observar una gota de líquido en la punta de la aguja.

- **No** tuerza o doble la cubierta de la aguja.
- **No** vuelva a colocar la cubierta de la aguja en la jeringa.
- **No** remueva la cubierta de la jeringa hasta no estar listo para la inyección.

Importante: Deseche la cubierta de la aguja en el recipiente para desechar objetos cortopunzantes.

F. Sujete el área de inyección para crear una superficie firme.

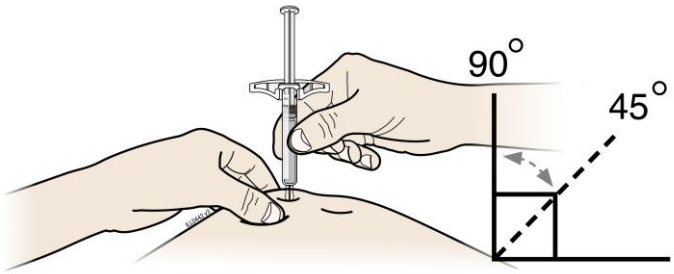


Sujete con firmeza un pliegue de piel entre el pulgar y los dedos, creando un área de aproximadamente **5** centímetros de ancho.

Importante: Continúe sujetando el pliegue de piel mientras aplica la inyección.

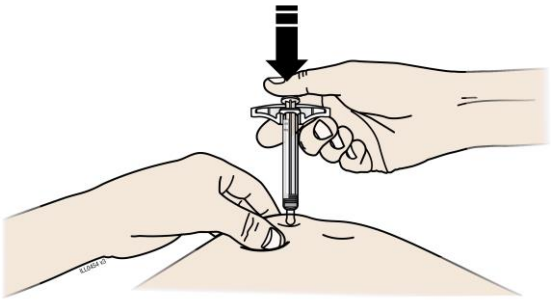
Paso 3: Aplicación de la inyección

G. Sujete el pliegue de piel. Después de retirar la cubierta de la aguja, introdúzcala dentro de su piel con un ángulo de 45 a 90 grados.

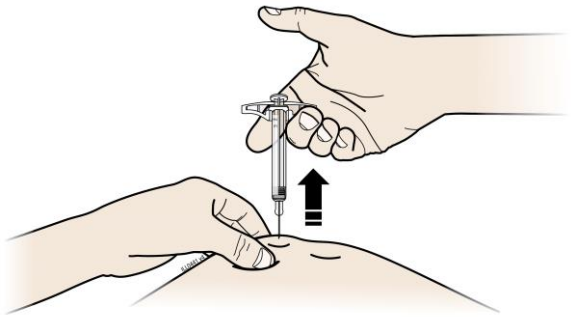


No coloque su dedo sobre el émbolo mientras introduce la aguja.

H. Aplicando presión lenta y constante, empuje el émbolo hacia abajo completamente hasta que se detenga.



I. Al terminar, suelte el pliegue de piel y, de forma cuidadosa, saque la aguja de su piel.



Paso 4: Finalización

J. Deseche la jeringa utilizada y la cubierta de la aguja.

- **No reutilice las jeringas.**
- **No** utilice el medicamento restante en la jeringa usada.
- Coloque la jeringa prellenada de AMGEVITA usada en un recipiente para desechar objetos cortopunzantes inmediatamente después de utilizarla. **No** arroje (deseche) la jeringa con los desechos domésticos.
- Pregunte a su médico o farmacéutico cómo eliminar correctamente las jeringas. Es posible que exista una normativa local al respecto.
- **No** recicle ni arroje a la basura doméstica la jeringa prellenada o el recipiente para desechar objetos cortopunzantes.

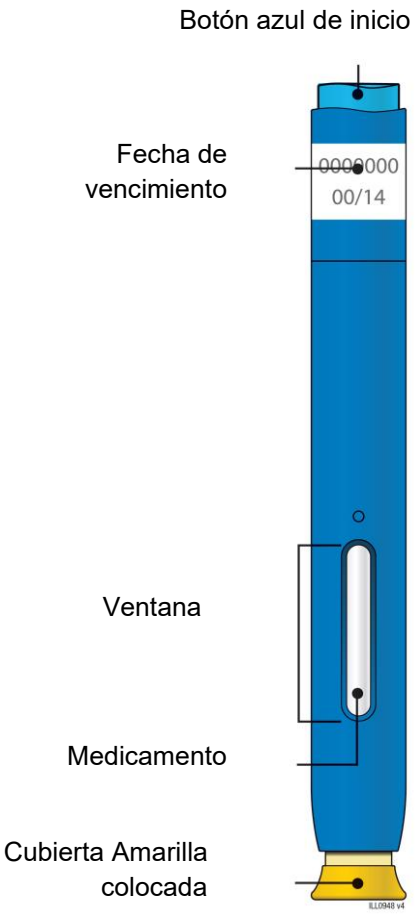
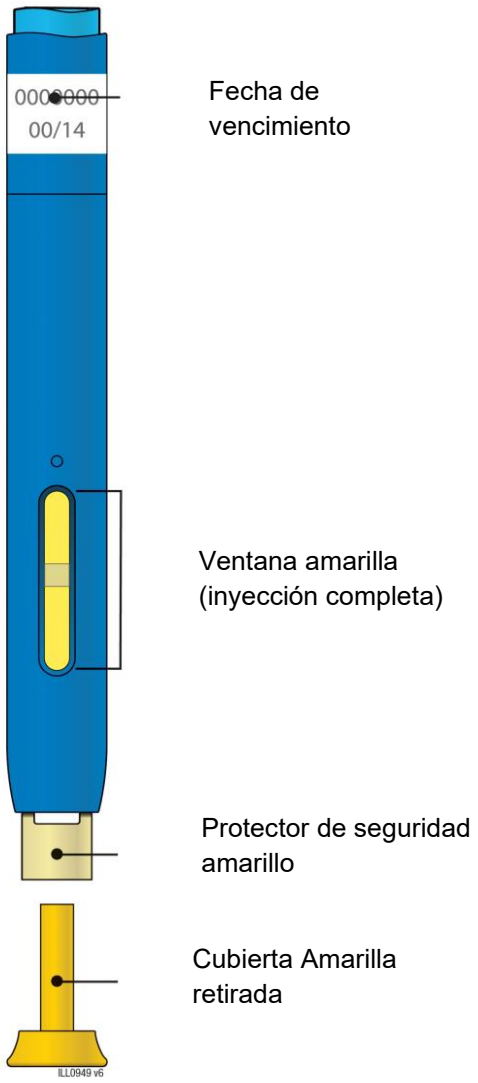
Importante: Siempre mantenga el recipiente para desechar objetos cortopunzantes fuera del alcance de los niños.

K. Examine el área de inyección.

Si observa sangre, presione el área de inyección con una bola de algodón o gasa. **No** frote el área de inyección. En caso de ser necesario, coloque una curita.

6.5.2 Instrucciones de Uso para AMGEVITA Autoinyector Prellenado (SureClick®)

Instrucciones de uso: AMGEVITA autoinyector prellenado SureClick de un solo uso Vía subcutánea

Guía de componentes	
Antes de usar	**Después de usar**
	
Importante: La aguja está en el interior	

Importante

Antes de utilizar un autoinyector prellenado de AMGEVITA, lea esta información importante:

Utilización del autoinyector prellenado de AMGEVITA

- Es importante que no intente autoadministrarse la inyección a menos que usted o su cuidador hayan recibido capacitación.
- **No** utilice un autoinyector prellenado de AMGEVITA si ha caído sobre una superficie dura. Es posible que algún componente del autoinyector prellenado de AMGEVITA esté roto, incluso si usted no lo nota. Utilice un nuevo autoinyector prellenado de AMGEVITA.
- La cubierta amarilla de la aguja del autoinyector prellenado de AMGEVITA está fabricado con caucho natural, que contiene látex. Informe a su profesional sanitario si es alérgico al látex.

Paso 1: Preparación

A. Saque el autoinyector prellenado de AMGEVITA del empaque.

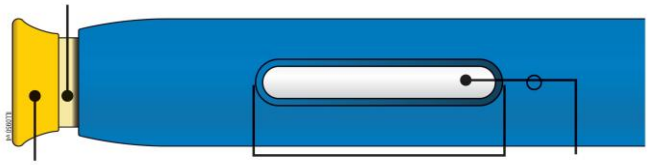
Retire con cuidado y en línea recta el autoinyector prellenado de la caja.

Vuelva a colocar el empaque original con los autoinyectores prellenados no utilizados en el refrigerador.

Para una administración más cómoda de la inyección, deje el autoinyector prellenado a temperatura ambiente entre **15 a 30** minutos antes de realizar la aplicación.

- **No** vuelva a guardar el autoinyector prellenado en el refrigerador una vez haya alcanzado la temperatura ambiente.
- **No** intente calentar el autoinyector prellenado utilizando fuentes de calor como agua caliente o el microondas.
- **No** agite el autoinyector prellenado.
- **No** retire todavía la cubierta amarilla del autoinyector prellenado.

B. Revise el autoinyector prellenado de AMGEVITA.



Cubierta amarilla colocada Ventana Medicamento

Asegúrese de que el medicamento en la ventana sea claro e incoloro a ligeramente amarillo.

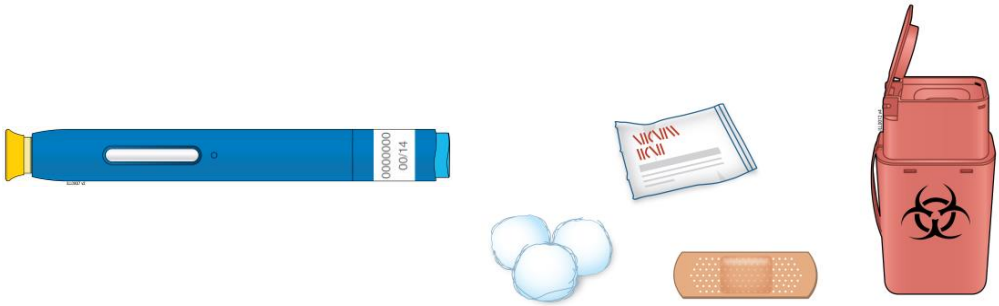
- **No** utilice el autoinyector prellenado si:
  - El medicamento luce turbio, presenta cambio de color o contiene copos o partículas.
  - Algún componente parece estar agrietado o roto.
  - Si el autoinyector prellenado se ha caído en una superficie dura.
  - Si la cubierta amarilla no está o está suelta.
  - Después de la fecha de vencimiento impresa en la etiqueta.

En cualquiera de estos casos, utilice un nuevo autoinyector prellenado.

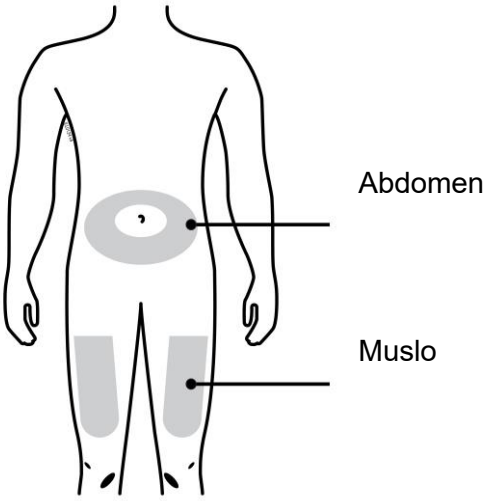
C. Reúna los implementos necesarios para su inyección.

Lave sus manos completamente con agua y jabón.
Sobre una superficie de trabajo limpia y bien iluminada, coloque un autoinyector prellenado nuevo.

Además, necesitará estos ítems adicionales, ya que no están incluidos en el empaque:
- Pañito impregnado de alcohol
- Bolas de algodón o trozos de gasa
- Una curita
- Recipiente para desechar objetos cortopunzantes



D. Prepare y limpie el área de inyección.

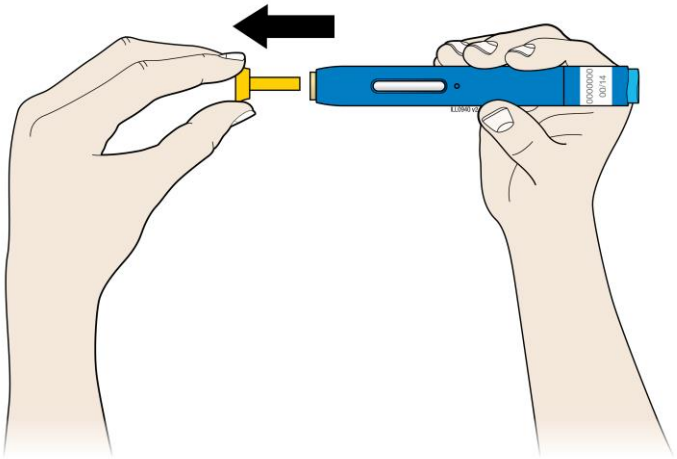


Puede utilizar:
- El muslo
- El abdomen, excepto un área de 2 pulgadas (**5** centímetros) alrededor del ombligo.

Limpie el área de inyección con un pañito impregnado de alcohol. Deje secar la piel.
- **No** toque de nuevo esa área antes de aplicar la inyección.
- Si desea utilizar la misma área de inyección, asegúrese de no utilizar el mismo punto que utilizó en la inyección anterior.
  - **No** aplique la inyección en áreas donde la piel esté sensible, con moretones, enrojecida o endurecida. Evite aplicar la inyección en áreas donde existan cicatrices o estrías.
- Si sufre de psoriasis, debe evitar inyectarse directamente en parches o lesiones de piel levantada, gruesa o escamada.

Paso 2: Alistamiento

E. Hale la cubierta amarilla hacia afuera y en línea recta cuando esté listo para la inyección.

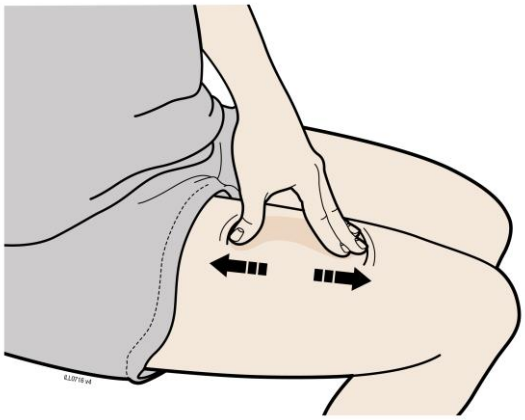


Es normal observar una gota de líquido en la punta de la aguja o del protector de seguridad amarillo.

- **No** tuerza o doble la cubierta amarilla.
- **No** vuelva a colocar la cubierta amarilla en el autoinyector prellenado.
- **No** remueva la cubierta amarilla del autoinyector prellenado hasta no estar listo para la inyección.

F. Estire o sujete un pliegue de piel en el área de inyección para crear una superficie firme.

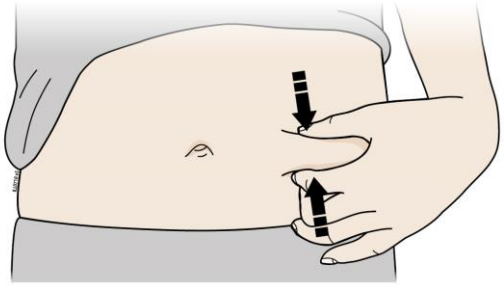
Método de estiramiento



Estire la piel con firmeza desplazando su pulgar y dedos en direcciones opuestas, para crear un área de aproximadamente 2 pulgadas (**5** centímetros) de ancho.

O

Método de pinzado

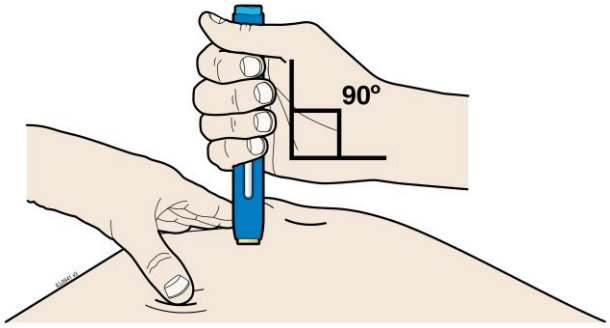


Sujete con firmeza un pliegue de piel entre el pulgar y los dedos, creando un área de aproximadamente 2 pulgadas (**5** centímetros) de ancho.

Importante: Continúe sujetando el pliegue de piel mientras aplica la inyección.

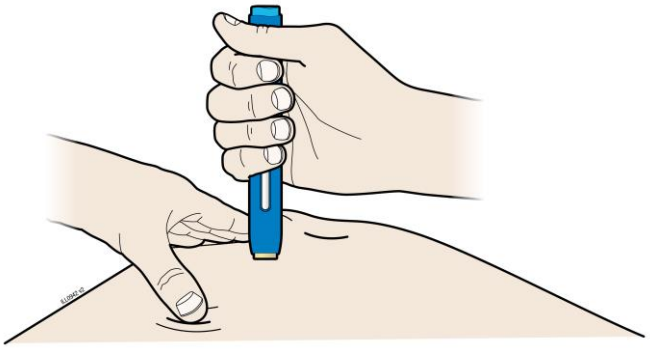
Paso 3: Inyección

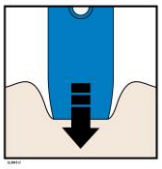
G. Mantenga la piel estirada o sujetada. Con la cubierta amarilla retirada, **ubique** el autoinyector prellenado sobre su piel con un ángulo de 90 grados.



Importante: Todavía no toque el botón de inicio azul.

H. Empuje firmemente el autoinyector prellenado sobre la piel hasta que deje de moverse.

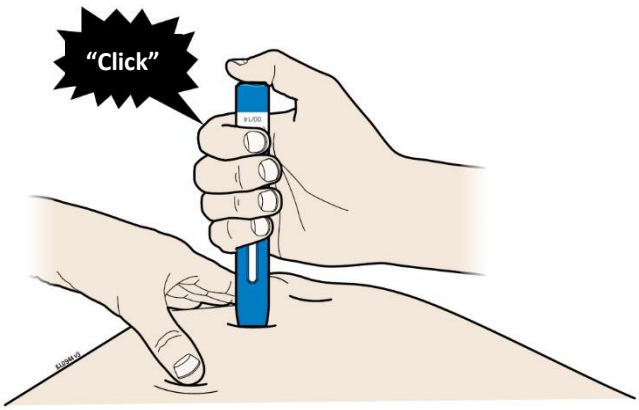




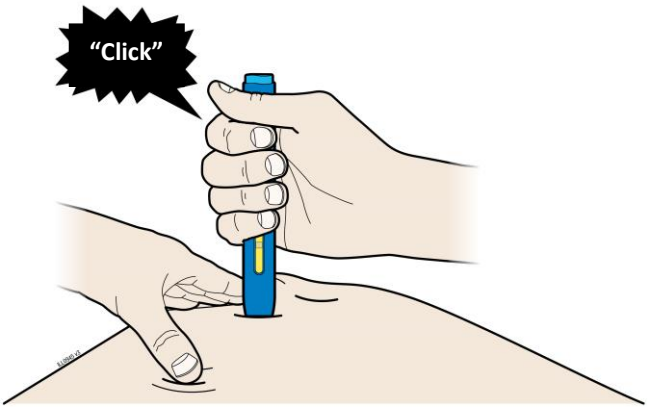
Empuje hacia abajo

Importante: Debe empujar el autoinyector prellenado tanto como sea posible pero no debe tocar el botón de inicio azul hasta estar listo para la inyección.

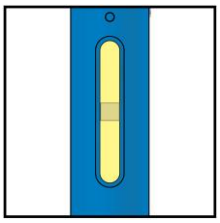
I. Cuando esté listo para la inyección, **presione** el botón de inicio azul. Oirá un click.



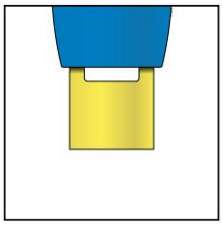
J. Continúe **empujando** el autoinyector prellenado hacia abajo sobre su piel. La inyección puede durar aproximadamente 10 segundos.



~10s



Al finalizar la inyección, la ventana se vuelve amarilla. Puede que oiga un segundo click.

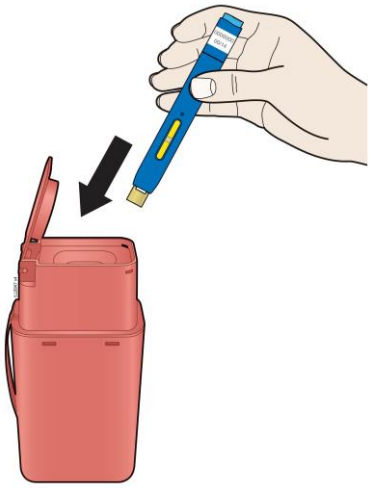


Nota: Después de retirar el autoinyector prellenado de su piel la aguja se cubrirá automáticamente.

Importante: Cuando retire el autoinyector prellenado, si la ventana no se volvió amarilla o si parece que aún se está administrando el medicamento, esto significa que no recibió la dosis completa. Comuníquese inmediatamente con su médico.

Paso 4: Finalización

K. Deseche el autoinyector prellenado usado y la cubierta amarilla.



- Inmediatamente después de utilizarlo, coloque el autoinyector prellenado usado en un recipiente para desechar objetos cortopunzantes. **No** arroje (deseche) el autoinyector prellenado con los desechos domésticos.
- Pregunte a su médico o farmacéutico cómo eliminar correctamente las plumas. Es posible que exista una normativa local al respecto.
- **No** reutilice el autoinyector prellenado.
- **No** recicle ni arroje con los desechos domésticos el autoinyector prellenado o el recipiente para desechar objetos cortopunzantes.

Importante: Siempre mantenga el recipiente para desechar objetos cortopunzantes fuera del alcance de los niños.

L. Examine el área de inyección.

Si observa sangre, presione el área de inyección con una bola de algodón o gasa. **No** frote el área de inyección. En caso de ser necesario, coloque una curita.

AMGEN®

Versión 3
Fecha de revisión: Septiembre de 2021